Tema: PEDIATRÍA / RECIÉN NACIDO SANO

Subtema: TRAUMA OBSTÉTRICO (CEFALOHEMATOMA)

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Recién nacido de término (39 SDG), producto de un parto vaginal prolongado e instrumentado con fórceps. A las 24 horas de vida, el pediatra nota aumento de volumen en la región parietal derecha del cráneo del neonato. A la palpación, la tumefacción es de consistencia renitente, no presenta cambios de coloración en la piel suprayacente y respeta claramente la línea de la sutura sagital, sin cruzar la línea media. El neonato se encuentra estable y con buena succión.

Pregunta 1

De acuerdo con las características de la tumefacción (aparición tardía y respeto de las líneas de sutura), ¿cuál es el diagnóstico clínico más probable?

A) Caput succedaneum

B) Cefalohematoma *

C) Hemorragia subgaleal

D) Fractura craneal con hundimiento

Retroalimentación:

El cefalohematoma es una hemorragia subperióstica, por lo que anatómicamente está delimitado por las inserciones del periostio en las suturas craneales (NO cruza las líneas de sutura). Suele aparecer horas o días después del parto y se asocia a partos instrumentados. Por el contrario, el caput succedaneum es un edema del tejido celular subcutáneo que aparece en el momento del parto y SÍ cruza las líneas de sutura. El tratamiento del cefalohematoma es conservador.

Tema: PEDIATRÍA / RECIÉN NACIDO SANO

Subtema: TRAUMA OBSTÉTRICO (PARÁLISIS BRAQUIAL)

Dificultad: Baja

Caso clínico (Corto):

Recién nacido macrosómico (4,200 g) tras parto vaginal complicado por distocia de hombros. A la exploración física inicial, se observa que el brazo derecho se encuentra en aducción y rotación interna, con el codo extendido, el antebrazo pronado y la muñeca flexionada (postura en "propina de mesero"). El reflejo de Moro es asimétrico (ausente del lado derecho) y el reflejo de prensión palmar está conservado en ambas manos.

Pregunta 1

¿Qué raíces nerviosas del plexo braquial están lesionadas en este tipo de parálisis obstétrica clásica?

A) C5 y C6 *

B) C7, C8 y T1

C) C8 y T1 exclusivamente

D) C3, C4 y C5

Retroalimentación:

La postura descrita corresponde a la Parálisis de Erb-Duchenne, que es la lesión del tronco superior del plexo braquial (raíces C5 y C6). Al estar afectadas estas raíces, se pierde la función del deltoides y bíceps, adoptando la clásica postura de "propina de mesero". El reflejo de prensión se mantiene intacto (a diferencia de la parálisis de Klumpke, que afecta C8-T1 y presenta mano en garra).

Tema: PEDIATRÍA / RECIÉN NACIDO SANO

Subtema: ALTERACIONES DERMATOLÓGICAS AL NACIMIENTO

Dificultad: Baja

Caso clínico (Corto):

Recién nacido de 2 días de vida, alimentado con seno materno exclusivo. La madre refiere estar preocupada porque hoy le aparecieron "ronchas" en el cuerpo. A la exploración, se observan múltiples máculas eritematosas, algunas con pequeñas pápulas y pústulas centrales de color blanco-amarillento, distribuidas en el tronco y las extremidades, respetando palmas y plantas. El neonato está afebril y luce sano.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico clínico de esta erupción cutánea benigna y qué hallazgo se esperaría encontrar si se realizara un frotis del contenido de la pústula (tinción de Wright)?

A) Melanosis pustulosa neonatal transitoria; abundantes neutrófilos

B) Eritema tóxico neonatal; abundantes eosinófilos *

C) Acné neonatal; abundantes linfocitos

D) Impétigo ampolloso; cocos grampositivos

Retroalimentación:

El eritema tóxico neonatal es la erupción cutánea benigna más frecuente en los recién nacidos a término. Aparece típicamente entre el 1er y 3er día de vida. Su sello patognomónico a nivel celular es la presencia de abundantes eosinófilos en el frotis de las lesiones. No requiere tratamiento y desaparece espontáneamente en una semana.

Tema: PEDIATRÍA / REANIMACIÓN NEONATAL

Subtema: PASOS INICIALES (MINUTO DE ORO)

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Se atiende el parto de un recién nacido de 38 SDG con antecedente de líquido amniótico claro. Al nacer, el neonato no llora, presenta tono muscular flácido y esfuerzo respiratorio ausente. El médico tratante lo lleva a la cuna radiante.

Pregunta 1

De acuerdo con la 8va edición del Manual de Reanimación Neonatal (NRP), tras colocar al neonato bajo la fuente de calor, posicionar la vía aérea, aspirar secreciones (si es necesario), secar y estimular, ¿cuál es el siguiente paso inmediato si el neonato permanece en apnea o con respiración jadeante (gasping)?

A) Administrar oxígeno a flujo libre al 100%

B) Iniciar compresiones torácicas inmediatamente

C) Iniciar Ventilación con Presión Positiva (VPP) con bolsa-mascarilla *

D) Intubación endotraqueal y administración de adrenalina

Retroalimentación:

Si un recién nacido se encuentra en apnea, con respiración jadeante (gasping) o tiene una frecuencia cardíaca menor a 100 lpm DESPUÉS de los pasos iniciales (calor, posición, secado y estimulación), el paso crítico y más importante de toda la reanimación neonatal es iniciar la Ventilación con Presión Positiva (VPP) dentro del primer minuto de vida ("Minuto de Oro").

Tema: PEDIATRÍA / RECIÉN NACIDO SANO

Subtema: TAMIZ NEONATAL METABÓLICO

Dificultad: Media

Caso clínico (Corto):

Recién nacido de término, sano, egresado a las 24 horas de vida junto con su madre. Acuden a consulta externa para revisión. El médico le informa a la madre que deben realizarle la prueba de tamiz metabólico neonatal.

Pregunta 1

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana (NOM-034-SSA2), ¿cuál es el periodo ideal establecido para la toma de la muestra de sangre (del talón) para el tamiz metabólico ampliado/básico?

A) Inmediatamente al nacer, con sangre del cordón umbilical

B) Entre el 3er y 5to día de vida *

C) Después de los 15 días de vida para asegurar una adecuada alimentación previa

D) Antes del alta hospitalaria, idealmente en las primeras 12 horas de vida

Retroalimentación:

El momento óptimo para la toma de la muestra del tamiz metabólico neonatal es entre el tercer y el quinto día de vida (72 a 120 horas). Tomarlo antes de las 48 horas puede arrojar falsos negativos en patologías como la fenilcetonuria (ya que el neonato necesita haber ingerido proteínas/leche materna para acumular los metabolitos) y falsos positivos en el perfil tiroideo por el pico de TSH postparto.

Tema: PEDIATRÍA / REANIMACIÓN NEONATAL

Subtema: LÍQUIDO AMNIÓTICO MECONIAL

Dificultad: Alta

Caso clínico (Medio):

Recién nacido de 40 SDG, se atiende el parto observando líquido amniótico teñido de meconio espeso ("puré de chícharos"). Al momento de nacer, el neonato se encuentra con tono muscular flácido, no respira (apnea) y tiene una frecuencia cardíaca de 80 lpm. Se lleva rápidamente a la cuna radiante.

Pregunta 1

Según las directrices actuales del Programa de Reanimación Neonatal (NRP 8va edición), ¿cuál es el paso inicial correcto en el manejo de la vía aérea de este paciente "no vigoroso" con líquido meconial?

A) Intubación endotraqueal inmediata para aspiración directa de la tráquea antes de secarlo

B) Realizar los pasos iniciales (calentar, posicionar, despejar secreciones con perilla bulbosa, secar, estimular) e iniciar VPP de inmediato *

C) Administrar presión positiva continua en la vía aérea (CPAP) con mascarilla

D) Realizar lavado bronquioalveolar con solución salina

Retroalimentación:

¡Punto clave de actualización ENARM! Anteriormente, la regla era intubar y aspirar la tráquea de rutina a todo neonato no vigoroso con meconio. La 8va edición del NRP eliminó esta recomendación. Ahora, ante un neonato con líquido meconial que NO está vigoroso (apnea, flacidez o FC < 100), se deben realizar los pasos iniciales normales (usando perilla para despejar boca y nariz) y pasar directamente a la Ventilación con Presión Positiva (VPP) si no mejora. Retrasar la ventilación para intubar aumenta la hipoxia y el riesgo de daño neurológico.

Tema: PEDIATRÍA / PATOLOGÍA NEONATAL INFECCIOSA

Subtema: SEPSIS NEONATAL TEMPRANA

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Recién nacido de 35 SDG, madre con antecedente de ruptura prematura de membranas de 24 horas y corioamnionitis (fiebre intraparto y taquicardia fetal). A las 12 horas de vida, el neonato presenta letargo, rechazo al alimento, inestabilidad térmica (hipotermia de 35.8°C) y dificultad respiratoria leve.

Pregunta 1

La presentación clínica antes de las 72 horas de vida en un prematuro con factores de riesgo maternos orienta fuertemente a una Sepsis Neonatal Temprana, cuyos agentes principales son Streptococcus agalactiae (Grupo B) y E. coli. Tras tomar hemocultivos y punción lumbar, ¿cuál es el esquema de antibioticoterapia empírica intravenosa de primera elección estipulado por las guías?

A) Vancomicina + Cefotaxima

B) Ampicilina + Gentamicina (o Amikacina) *

C) Ceftriaxona + Clindamicina

D) Penicilina G sódica en monoterapia

Retroalimentación:

El esquema empírico de elección mundial para la sepsis neonatal temprana es Ampicilina (cubre S. agalactiae y Listeria monocytogenes) más un Aminoglucósido como la Gentamicina o Amikacina (para cubrir bacilos gramnegativos como E. coli). La Ceftriaxona está contraindicada en neonatos porque desplaza la bilirrubina de la albúmina, aumentando el riesgo de kernicterus.

Tema: PEDIATRÍA / PATOLOGÍA NEONATAL INFECCIOSA

Subtema: ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE (ECN)

Dificultad: Alta

Caso clínico (Corto):

Recién nacido prematuro de 28 SDG, con peso al nacer de 1,100 gramos. En su segunda semana de vida, mientras se encuentra en la UCIN recibiendo alimentación enteral con fórmula, presenta súbitamente distensión abdominal importante, residuo gástrico bilioso, rectorragia (sangre en heces) y episodios de apnea.

Pregunta 1

Ante la alta sospecha clínica de Enterocolitis Necrotizante, se solicita una radiografía simple de abdomen. ¿Cuál es el hallazgo radiológico patognomónico que confirma el diagnóstico de ECN (Estadio II de Bell) y orienta el manejo?

A) Signo de la doble burbuja

B) Neumatosis intestinal (aire en la pared del intestino) *

C) Niveles hidroaéreos en escalera con ausencia de gas distal

D) Neumoperitoneo masivo (Signo de Rigler)

Retroalimentación:

La neumatosis intestinal (aire dentro del espesor de la pared intestinal) es el signo radiológico patognomónico de la ECN y define el Estadio II de los criterios de Bell. Ocurre porque las bacterias productoras de gas invaden la mucosa isquémica del intestino. Si la radiografía mostrara neumoperitoneo (aire libre), indicaría perforación intestinal, lo que clasifica al paciente en Estadio III y es indicación quirúrgica absoluta.

Tema: PEDIATRÍA / PATOLOGÍA NEONATAL INFECCIOSA

Subtema: ONFALITIS

Dificultad: Baja

Caso clínico (Corto):

Recién nacido de 8 días de vida, es llevado a la consulta de niño sano porque la madre nota mal olor y salida de escaso material purulento a través del muñón umbilical. A la exploración física, se observa eritema e induración en la piel periumbilical que se extiende aproximadamente 3 mm alrededor del anillo. El niño está afebril, come bien y luce reactivo.

Pregunta 1

Sabiendo que el agente etiológico más frecuentemente aislado es Staphylococcus aureus, ¿cuál es el tratamiento de elección inicial para esta onfalitis no complicada con un área de eritema menor a 5 mm y sin signos de afección sistémica?

A) Antibioticoterapia tópica (Mupirocina o Neomicina) y medidas de higiene local *

B) Cefotaxima intravenosa y hospitalización urgente en la UCIN

C) Resección quirúrgica inmediata del tejido umbilical

D) Penicilina G benzatínica intramuscular en dosis única

Retroalimentación:

La onfalitis leve (área eritematosa < 5 mm sin signos sistémicos) puede manejarse de forma ambulatoria con ungüentos antibióticos tópicos como Mupirocina, lavado con agua y jabón, y vigilancia estrecha. Si el eritema sobrepasa los 5 mm, hay fiebre, ictericia o letargo, el neonato debe ser hospitalizado inmediatamente para recibir antibióticos intravenosos por el altísimo riesgo de sepsis o trombosis de la vena porta.

Tema: PEDIATRÍA / PATOLOGÍA NEONATAL INFECCIOSA

Subtema: MENINGITIS NEONATAL

Dificultad: Media

Caso clínico (Corto):

Recién nacido de 15 días de vida, acude a urgencias por fiebre de 39°C, irritabilidad extrema, llanto agudo ("grito cefálico") y rechazo al seno materno. A la exploración física, no presenta rigidez de nuca, pero destaca la fontanela anterior francamente abombada y tensa. Se realiza punción lumbar obteniendo líquido cefalorraquídeo (LCR) de aspecto turbio.

Pregunta 1

¿Cuáles son los hallazgos citoquímicos clásicos que esperaría encontrar en el LCR de este paciente que confirman una etiología bacteriana?

A) Pleocitosis de predominio mononuclear (linfocitos), glucosa normal y proteínas normales

B) Pleocitosis de predominio polimorfonuclear (neutrófilos), hipoglucorraquia y proteínas elevadas (hiperproteinorraquia) *

C) Presencia de abundantes eritrocitos crenados y xantocromía franca

D) LCR completamente acelular con glucosa marcadamente elevada

Retroalimentación:

El patrón citoquímico del LCR en la meningitis bacteriana neonatal se caracteriza por pleocitosis con predominio de polimorfonucleares (> 80%), consumo de glucosa por las bacterias (hipoglucorraquia < 40 mg/dL o < 50% de la glucosa sérica) y aumento de proteínas (> 100-150 mg/dL) debido a la inflamación meníngea. Nota clínica: en los neonatos, los signos meníngeos clásicos (Kernig/Brudzinski o rigidez de nuca) suelen estar ausentes; el abombamiento de la fontanela y la irritabilidad son los signos cardinales.

Tema: PEDIATRÍA / PATOLOGÍA RESPIRATORIA NEONATAL

Subtema: ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA (SDR TIPO I)

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Recién nacido prematuro de 29 SDG, obtenido por cesárea de urgencia por preeclampsia severa, sin esquema de maduración pulmonar previo. A los pocos minutos de nacer, inicia con dificultad respiratoria severa: aleteo nasal, quejido espiratorio audible, tiraje intercostal y disociación tóraco-abdominal (Silverman-Andersen de 7). La radiografía de tórax muestra un patrón reticulonodular difuso bilateral ("en vidrio esmerilado"), con disminución del volumen pulmonar y presencia de broncograma aéreo.

Pregunta 1

La presentación clínica en un prematuro extremo y el patrón radiológico en "vidrio esmerilado" son clásicos de la Enfermedad de Membrana Hialina. ¿Cuál es el déficit fisiopatológico primario que causa esta enfermedad y cuál es el tratamiento de primera línea tras la estabilización inicial?

A) Retención de líquido pulmonar fetal / Presión positiva continua en la vía aérea (CPAP) exclusivamente

B) Déficit de producción de surfactante / Administración de surfactante exógeno intratraqueal y CPAP nasal *

C) Aspiración de meconio intraútero / Lavado bronquioalveolar y ventilación mecánica

D) Ruptura alveolar por barotrauma / Colocación de sonda endopleural de urgencia

Retroalimentación:

La Enfermedad de Membrana Hialina (SDR tipo I) ocurre por la inmadurez de los neumocitos tipo II, lo que resulta en una producción deficiente de surfactante pulmonar. Esto genera colapso alveolar (atelectasia progresiva). El tratamiento angular es el soporte ventilatorio (CPAP temprano para mantener los alvéolos abiertos) y la administración de surfactante exógeno por tubo endotraqueal o técnicas mínimamente invasivas (MISA/LISA).

Tema: PEDIATRÍA / PATOLOGÍA RESPIRATORIA NEONATAL

Subtema: TAQUIPNEA TRANSITORIA DEL RECIÉN NACIDO (SDR TIPO II)

Dificultad: Baja

Caso clínico (Corto):

Recién nacido de término (38 SDG), obtenido por cesárea electiva sin trabajo de parto previo. A las 2 horas de vida, el neonato presenta taquipnea de 75 respiraciones por

minuto y leve tiraje intercostal, sin cianosis. Se solicita una radiografía de tórax que evidencia hiperinsuflación pulmonar, congestión perihiliar (trama vascular prominente) y la presencia de líquido en las cisuras interlobares (cisuritis).

Pregunta 1

La historia clínica de cesárea sin trabajo de parto y la imagen radiológica de "cisuritis" establecen el diagnóstico de Taquipnea Transitoria del Recién Nacido. ¿A qué alteración fisiopatológica se debe este cuadro que suele ser autolimitado y benigno?

A) Obstrucción de la vía aérea por aspiración de sangre materna

B) Retraso en la reabsorción del líquido pulmonar fetal por falta del estímulo catecolaminérgico del trabajo de parto *

C) Infección bacteriana in utero por Streptococcus agalactiae

D) Destrucción mediada por anticuerpos del surfactante pulmonar

Retroalimentación:

La Taquipnea Transitoria del Recién Nacido (TTRN) ocurre clásicamente en niños de término o casi término nacidos por cesárea electiva. Durante el trabajo de parto normal, el estrés libera catecolaminas que activan los canales de sodio (ENaC), cambiando el pulmón de un órgano "secretor" a uno "absorbedor" de líquido. Sin este estrés, el líquido pulmonar se retiene en los linfáticos y el espacio intersticial, causando el edema que se ve en la radiografía como líquido en las cisuras. El manejo es de soporte (oxígeno en casco cefálico o CPAP) y resuelve en 24-72 horas.

Tema: PEDIATRÍA / PATOLOGÍA RESPIRATORIA NEONATAL

Subtema: SÍNDROME DE ASPIRACIÓN DE MECONIO (SAM)

Dificultad: Alta

Caso clínico (Medio):

Recién nacido postérmino (41 SDG), con antecedente de sufrimiento fetal agudo (bradicardia fetal sostenida) y líquido amniótico teñido de meconio espeso ("puré de chícharos"). Nace deprimido y requiere reanimación avanzada. Posteriormente en la UCIN, desarrolla dificultad respiratoria severa, tórax en tonel e hipoxemia profunda que no responde al aumento de la FiO2. La radiografía de tórax revela opacidades algodonosas asimétricas ("en parches"), áreas de hiperinsuflación y aplanamiento de los hemidiafragmas.

Pregunta 1

El Síndrome de Aspiración de Meconio causa obstrucción mecánica ("efecto de válvula") y neumonitis química. Debido a la hipoxia y acidosis severas y sostenidas, ¿cuál es la complicación cardiovascular más temida y frecuente asociada al SAM que causa hipoxemia refractaria al desviar la sangre de derecha a izquierda?

A) Persistencia del conducto arterioso

B) Hipertensión Pulmonar Persistente del Recién Nacido (HPPRN) *

C) Comunicación interventricular sintomática

D) Coartación de la aorta preductal

Retroalimentación:

La Hipertensión Pulmonar Persistente del Recién Nacido (HPPRN) es la complicación más grave del SAM. El meconio, la hipoxia crónica y la acidosis impiden que la resistencia vascular pulmonar caiga al nacer. Como la presión en el lado derecho del corazón se mantiene altísima, la sangre se salta los pulmones pasando de derecha a izquierda a través del foramen oval y el conducto arterioso (cortocircuito fetal), provocando una hipoxemia que no mejora con oxígeno. Su tratamiento requiere óxido nítrico inhalado o ECMO.

Tema: PEDIATRÍA / PATOLOGÍA RESPIRATORIA NEONATAL

Subtema: DISPLASIA BRONCOPULMONAR (DBP)

Dificultad: Media

Caso clínico (Corto):

Recién nacido prematuro de 26 SDG, con peso al nacer de 800 gramos. Durante su estancia en la UCIN, presentó Enfermedad de Membrana Hialina grave y requirió ventilación mecánica invasiva por 21 días. Actualmente tiene 32 días de vida y sigue requiriendo oxígeno suplementario por cánulas nasales para mantener saturaciones > 90%. La radiografía de tórax muestra un patrón espongiforme con áreas de hiperclaridad quística alternadas con tractos fibróticos.

Pregunta 1

El daño pulmonar crónico secundario al barotrauma, volutrauma y toxicidad por oxígeno en un pulmón inmaduro define a la Displasia Broncopulmonar (DBP). Según los criterios diagnósticos internacionales, ¿a partir de qué momento de vida cronológica o edad postmenstrual (corregida) la necesidad continua de oxígeno suplementario define el diagnóstico de DBP en prematuros menores de 32 semanas?

A) Necesidad de oxígeno por más de 7 días de vida

B) Necesidad de oxígeno a los 14 días de vida

C) Necesidad de oxígeno suplementario durante al menos 28 días o al llegar a las 36 semanas de edad postmenstrual *

D) Necesidad de oxígeno al momento del egreso hospitalario, sin importar la edad

Retroalimentación:

La Displasia Broncopulmonar es la enfermedad pulmonar crónica de la prematuridad. El criterio diagnóstico temporal estandarizado exige que el neonato haya requerido oxígeno suplementario (FiO_2 > 21%) durante al menos 28 días de vida. La severidad (leve, moderada, grave) se evalúa a las 36 semanas de edad postmenstrual (PMA), dependiendo de la cantidad de soporte ventilatorio o fracción de oxígeno que siga necesitando en ese momento crítico del desarrollo.

Tema: PEDIATRÍA / PATOLOGÍA NEONATAL

Subtema: APNEA DEL PREMATURO

Dificultad: Baja

Caso clínico (Corto):

Recién nacido prematuro de 30 SDG, cursando su cuarto día de vida en la UCIN. Las enfermeras reportan que el neonato presenta múltiples episodios diarios en los que deja de respirar por periodos de 22 a 25 segundos, los cuales se acompañan consistentemente de bradicardia (FC < 80 lpm) y desaturación (SpO2 < 85%). Al ser estimulado táctilmente, el neonato reinicia la respiración.

Pregunta 1

Se descartan causas secundarias (sepsis, hipoglucemia, anemia) y se diagnostica Apnea de la Prematuridad, debida a la inmadurez del centro respiratorio en el tronco encefálico. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico de elección (una metilxantina) para estimular el impulso respiratorio central en este paciente?

A) Dexametasona intravenosa

B) Citrato de Cafeína *

C) Salbutamol nebulizado

D) Surfactante intratraqueal

Retroalimentación:

El Citrato de Cafeína es el fármaco de elección mundial para el tratamiento profiláctico y terapéutico de la apnea del prematuro. Pertenece al grupo de las metilxantinas y actúa antagonizando los receptores de adenosina en el tronco encefálico, lo que aumenta la sensibilidad del centro respiratorio al CO2 y mejora la contractilidad diafragmática. Es preferible a la aminofilina/teofilina por tener una vida

media más larga, mayor índice terapéutico y menos efectos secundarios cardiovasculares.

Tema: PEDIATRÍA / DEFECTOS DE PARED ABDOMINAL

Subtema: ONFALOCELE VS GASTROSQUISIS

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Recién nacido de término, obtenido por parto vaginal. A la exploración física inmediata se observa un defecto en la pared abdominal de 4 cm, localizado a la derecha del cordón umbilical. Las asas intestinales están expuestas, se observan edematosas, con una capa de fibrina y NO están cubiertas por ningún saco o membrana. El cordón umbilical se inserta normalmente en la pared abdominal.

Pregunta 1

De acuerdo con la localización del defecto y la ausencia de saco protector, ¿cuál es el diagnóstico más probable y cuál es la asociación más frecuentemente encontrada en esta patología?

A) Onfalocele; Asociado a trisomía 13, 18 y 21

B) Gastrosquisis; Asociado a atresia intestinal por compromiso vascular *

C) Hernia umbilical; Asociado a hipotiroidismo congénito

D) Pentalogía de Cantrell; Asociado a ectopia cordis

Retroalimentación:

La gastrosquisis es un defecto paraumbilical (generalmente derecho) donde las asas están descubiertas y expuestas al líquido amniótico (causando la serositis/fibrina). A diferencia del onfalocele, la gastrosquisis rara vez se asocia a anomalías cromosómicas, pero sí a atresias intestinales. El onfalocele ocurre en el mismo anillo umbilical y las vísceras (incluyendo hígado a veces) están cubiertas por un saco de peritoneo y amnios.

Tema: PEDIATRÍA / PATOLOGÍA QUIRÚRGICA NEONATAL

Subtema: HERNIA DIAFRAGMÁTICA CONGÉNITA (BOCHDALEK)

Dificultad: Alta

Caso clínico (Medio):

Recién nacido de 38 SDG que presenta dificultad respiratoria grave desde el primer minuto de vida, cianosis y abdomen excavado (escafoide). A la auscultación, los ruidos cardíacos están desplazados a la derecha y se escuchan ruidos hidroaéreos en el hemitórax izquierdo. Se intenta estabilizar con bolsa-valvula-mascarilla (VPP) pero el paciente empeora rápidamente.

Pregunta 1

Ante la sospecha de Hernia de Bochdalek, ¿cuál es la primera acción contraindicada en la reanimación de este paciente y cuál es el paso inicial correcto para el manejo ventilatorio?

A) Contraindicado: Intubación; Correcto: VPP con mascarilla

B) Contraindicado: VPP con mascarilla; Correcto: Intubación endotraqueal inmediata *

C) Contraindicado: Sonda orogástrica; Correcto: Oxígeno a flujo libre

D) Contraindicado: Sedación; Correcto: Traqueostomía de urgencia

Retroalimentación:

En la Hernia Diafragmática (especialmente la de Bochdalek, que es posterolateral izquierda en el 85% de los casos), la Ventilación con Presión Positiva (VPP) con mascarilla está ABSOLUTAMENTE contraindicada, ya que el aire entra al estómago y asas intestinales herniadas, comprimiendo más el pulmón hipoplásico. El manejo inicial es intubación endotraqueal inmediata y colocación de una sonda nasogástrica de doble vía para descompresión gástrica.

Tema: PEDIATRÍA / PATOLOGÍA QUIRÚRGICA NEONATAL

Subtema: ATRESIA DE ESÓFAGO

Dificultad: Media

Caso clínico (Corto):

Recién nacido que desde el nacimiento presenta sialorrea abundante (salivación excesiva), cianosis y asfixia inmediata al intentar la alimentación al seno materno. Se intenta pasar una sonda radiopaca hacia el estómago, pero se encuentra resistencia a los 10 cm de la arcada dentaria. La radiografía de tórax y abdomen muestra la sonda enrollada en el saco esofágico superior y presencia de aire en el estómago y resto del intestino.

Pregunta 1

¿Cuál es el tipo de atresia esofágica más frecuente según la clasificación de Vogt/Ladd y qué malformaciones asociadas deben buscarse intencionadamente (VACTERL)?

A) Tipo I (Atresia pura sin fístula); Asociación con malformaciones renales

B) Tipo III o C (Atresia proximal con fístula distal); Asociación VACTERL *

C) Tipo IV o D (Fístula proximal y distal); Asociación con trisomía 18

D) Tipo V o E (Fístula en H sin atresia); Asociación con cardiopatía congénita

Retroalimentación:

La atresia de esófago tipo III (o C) es la más común (85-90%). Se caracteriza por un saco esofágico ciego proximal y una fístula que comunica la tráquea con el segmento distal del esófago (por eso hay aire en el estómago). Siempre debe descartarse la asociación VACTERL (Vertebrales, Anales, Cardíacas, Traqueoesofágicas, Renales y de Extremidades/Limbs).

Tema: PEDIATRÍA / PATOLOGÍA QUIRÚRGICA NEONATAL

Subtema: ATRESIA DUODENAL

Dificultad: Media

Caso clínico (Corto):

Neonato de 2 días de vida que presenta vómitos biliosos desde las primeras horas de vida. No hay distensión abdominal (el abdomen es plano o excavado). La madre tiene antecedente de polihidramnios durante el embarazo. En la radiografía simple de abdomen se observa el signo de la "doble burbuja" y ausencia total de gas distal.

Pregunta 1

Este hallazgo radiológico es característico de la atresia duodenal. ¿A qué patología cromosómica se asocia esta malformación en un 30% de los casos?

A) Síndrome de Turner

B) Síndrome de Patau (Trisomía 13)

C) Síndrome de Down (Trisomía 21) *

D) Síndrome de Edwards (Trisomía 18)

Retroalimentación:

La atresia duodenal ocurre por una falta de recanalización de la luz duodenal. La imagen de "doble burbuja" (estómago y duodeno proximal dilatados) es patognomónica. Su asociación con el Síndrome de Down es un "clásico" del ENARM. Los vómitos son biliosos porque la obstrucción suele ser post-ampular (distal a la ampolla de Vater).

[Image of double bubble sign in duodenal atresia x-ray]

Tema: PEDIATRÍA / PATOLOGÍA NEONATAL

Subtema: PERSISTENCIA DEL CONDUCTO ARTERIOSO (PCA)

Dificultad: Baja

Caso clínico (Corto):

Recién nacido prematuro de 30 SDG que al quinto día de vida presenta deterioro respiratorio, pulsos saltones y un soplo continuo, rudo, en maquinaria (de Gibson) audible en la región infraclavicular izquierda.

Pregunta 1

¿Cuál es el fármaco de elección (inhibidor de la síntesis de prostaglandinas) para intentar el cierre farmacológico del conducto arterioso en este prematuro?

A) Alprostadil (Prostaglandina E1)

B) Indometacina o Ibuprofeno *

C) Digoxina

D) Espironolactona

Retroalimentación:

En el prematuro con PCA sintomática, el tratamiento de primera línea para inducir el cierre es el uso de inhibidores de la ciclooxigenasa (COX), como la Indometacina o el Ibuprofeno (este último con menos efectos renales). Si el paciente fuera un neonato con una cardiopatía cianógena dependiente de conducto, se usaría Alprostadil para mantenerlo abierto.

Tema: PEDIATRÍA / GASTROENTEROLOGÍA NEONATAL

Subtema: ICTERICIA FISIOLÓGICA VS PATOLÓGICA

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Recién nacido de término (39 SDG), de 18 horas de vida, alimentado con seno materno. La enfermera nota coloración amarillenta de piel que llega hasta el tronco (Kramer II). Al interrogatorio, la madre refiere ser O Rh positivo y el neonato es A Rh positivo. Laboratorios: Bilirrubina Total (BT) de 13 mg/dl a expensas de la indirecta. El reporte de Coombs directo es negativo.

Pregunta 1

¿Cuál es la característica principal en este caso que define a esta ictericia como PATOLÓGICA en lugar de fisiológica?

A) El nivel de bilirrubina de 13 mg/dl

B) La alimentación con seno materno

C) Su aparición antes de las 24 horas de vida *

D) El tipo de sangre de la madre

Retroalimentación:

Toda ictericia que aparece en las primeras 24 horas de vida se considera PATOLÓGICA hasta demostrar lo contrario. La ictericia fisiológica suele aparecer después del 2do o 3er día, no suele elevarse más de 5 mg/dl por día y no supera los 15 mg/dl en neonatos a término. En este caso, al ser el Coombs negativo, se descarta hemólisis por isoinmunización, pero el tiempo de aparición obliga a investigar otras causas (sepsis, TORCH, etc.).

Tema: PEDIATRÍA / HEMATOLOGÍA NEONATAL

Subtema: ISOINMUNIZACIÓN MATERNO-FETAL (Rh)

Dificultad: Alta

Caso clínico (Medio):

Femenina multigesta (G3, P2) con grupo sanguíneo O Rh negativo. No recibió profilaxis con inmunoglobulina anti-D en sus embarazos previos. Recién nacido actual de 39 SDG, grupo A Rh positivo. A las 6 horas de vida presenta ictericia intensa (Kramer IV), hepatoesplenomegalia y palidez de tegumentos. Laboratorios: Hemoglobina 10 g/dl, BT 18 mg/dl (indirecta), Coombs directo fuertemente positivo (++++).

Pregunta 1

Ante un neonato con anemia hemolítica grave e hiperbilirrubinemia severa por incompatibilidad a Rh, ¿cuál es el tratamiento de elección para evitar el daño neurológico permanente (Kernicterus) si los niveles de bilirrubina se encuentran en el rango de riesgo según las curvas de severidad?

A) Fototerapia simple con luz azul

B) Exanguinotransfusión *

C) Administración de fenobarbital

D) Hidratación oral con fórmula láctea

Retroalimentación:

La exanguinotransfusión es el procedimiento de elección en casos de hemólisis grave con niveles de bilirrubina que cruzan el umbral de riesgo (usualmente >20 mg/dl en término, o menor en prematuros/enfermos) para remover anticuerpos maternos y bilirrubina circulante rápidamente. El Kernicterus afecta principalmente a los ganglios basales (globo pálido).

Tema: PEDIATRÍA / TRASTORNOS METABÓLICOS NEONATALES

Subtema: HIPOGLUCEMIA NEONATAL

Dificultad: Media

Caso clínico (Corto):

Recién nacido de 38 SDG, hijo de madre con Diabetes Mellitus tipo 2 gestacional mal controlada. Peso al nacer: 4,500 g (Macrosómico). A las 2 horas de vida, el neonato presenta temblores (jitteriness), irritabilidad, succión débil y episodios de cianosis peribucal. Se realiza toma de glucemia capilar reportando 35 mg/dl.

Pregunta 1

De acuerdo con las Guías de Práctica Clínica, ¿cuál es el punto de corte (mg/dl) para definir hipoglucemia neonatal en las primeras 24 horas y cuál es el manejo inicial en este paciente sintomático?

A) < 45 mg/dl; Iniciar carga de Glucosa al 10% (2 ml/kg) IV *

B) < 60 mg/dl; Dar fórmula láctea vía oral

C) < 40 mg/dl; Mantener en ayuno y observar

D) < 50 mg/dl; Administrar Glucagón IM

Retroalimentación:

En México y por la AAP, se acepta <45-47 mg/dl como umbral de hipoglucemia. Si el paciente presenta SÍNTOMAS (temblores, apnea, cianosis), el manejo debe ser inmediato con un bolo de solución glucosada al 10% (mini-dosis de 2 ml/kg) seguido de una infusión continua (VIG). El hijo de madre diabética es el caso clínico clásico por el hiperinsulinismo fetal.

Tema: PEDIATRÍA / TRASTORNOS METABÓLICOS NEONATALES

Subtema: HIPOCALCEMIA NEONATAL

Dificultad: Media

Caso clínico (Corto):

Recién nacido prematuro de 32 SDG. A las 48 horas de vida presenta movimientos de extremidades tipo sacudidas, estridor laringeo y signo de Chvostek positivo. Se documenta calcio sérico total de 6.2 mg/dl (normal >7.0 en prematuros).

Pregunta 1

¿Cuál es el tratamiento de urgencia indicado para la corrección de hipocalcemia neonatal sintomática y qué monitoreo es estrictamente necesario durante su administración?

A) Gluconato de calcio al 10% IV; Monitoreo cardiaco (riesgo de bradicardia) *

B) Carbonato de calcio vía oral; Monitoreo de glucosa

C) Vitamina D3 intramuscular; Monitoreo de diuresis

D) Sulfato de Magnesio; Monitoreo de reflejos osteotendinosos

Retroalimentación:

La hipocalcemia sintomática se trata con Gluconato de Calcio al 10% intravenoso. Es vital realizar monitoreo cardiaco continuo durante la infusión, ya que puede causar bradicardia severa o arritmias si se administra muy rápido. El signo de Chvostek (espasmo facial al golpear el nervio facial) es un dato clínico característico.

Tema: PEDIATRÍA / ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO

Subtema: FENILCETONURIA (PKU)

Dificultad: Alta

Caso clínico (Corto):

Lactante de 4 meses de edad es llevado a consulta por retraso en el desarrollo psicomotor. La madre refiere que la orina del bebé tiene un "olor muy fuerte, como a ratón o humedad". A la exploración, destaca que el lactante tiene piel muy clara y ojos azules, a pesar de que ambos padres son de fenotipo moreno. El tamiz neonatal no se realizó.

Pregunta 1

¿Cuál es la deficiencia enzimática que causa esta patología y cuál es el aminoácido que se vuelve "esencial" debido a que no se puede producir a partir de la fenilalanina?

A) Fenilalanina hidroxilasa / Tirosina *

B) Tirosinasa / Melanina

C) Galactosa-1-fosfato uridiltransferasa / Glucosa

D) Cistationina sintetasa / Cisteína

Retroalimentación:

La Fenilcetonuria (PKU) es causada por el déficit de la enzima **Fenilalanina hidroxilasa**, encargada de convertir la fenilalanina en tirosina. El olor a "ratón" o "moho" en la orina se debe a los metabolitos (ácido fenilacético). La falta de tirosina explica la hipopigmentación (piel clara/ojos azules) ya que la tirosina es precursora de la melanina.

Tema: PEDIATRÍA / CRECIMIENTO Y DESARROLLO

Subtema: SOMATOMETRÍA Y FÓRMULAS DE CRECIMIENTO

Dificultad: Baja

Caso clínico (Corto):

Lactante masculino de 12 meses de edad es llevado a consulta de niño sano. Al nacer pesó 3,200 g y midió 50 cm. El niño se ha alimentado adecuadamente y no tiene antecedentes de enfermedades de importancia.

Pregunta 1

De acuerdo con los parámetros normales de crecimiento esperados para un lactante sano al cumplir el primer año de vida, ¿cuál debería ser aproximadamente su peso y su talla actual?

A) Duplicar el peso al nacer y aumentar 15 cm la talla

B) Triplicar el peso al nacer y aumentar el 50% de la talla inicial *

C) Cuadruplicar el peso al nacer y duplicar la talla inicial

D) Aumentar 5 kg de peso y 10 cm de talla independientemente del peso inicial

Retroalimentación:

Regla de oro de somatometría: 1) El peso se DUPLICA a los 4-5 meses, se TRIPLICA al año y se CUADRUPLICA a los 2 años. 2) La talla aumenta un 50% al primer año (ej. de 50 cm a 75 cm) y se DUPLICA a los 4 años (100 cm). En este caso, el niño debería pesar ~9,600 g y medir ~75 cm.

Tema: PEDIATRÍA / CRECIMIENTO Y DESARROLLO

Subtema: HITOS DEL DESARROLLO PSICOMOTOR

Dificultad: Media

Caso clínico (Corto):

Lactante de 8 meses de edad acude a revisión. La madre está orgullosa porque el niño ya se mantiene sentado solo sin apoyo, puede pasar un juguete de una mano a otra y balbucea sílabas como "da-da" o "ma-ma".

Pregunta 1

¿Cuál de los siguientes hitos del desarrollo motor grueso es el que se espera que este paciente logre alcanzar cronológicamente en el siguiente nivel (entre los 9 y 10 meses)?

A) Correr y subir escaleras

B) Gateo y ponerse de pie con apoyo (bipedestación con apoyo) *

C) Marcha independiente (caminar solo)

D) Saltar en dos pies

Retroalimentación:

Hitos clave: Sostén cefálico (3 meses), rodamiento (4-5 meses), sedestación sin apoyo (6-7 meses), gateo y bipedestación con apoyo (9-10 meses) y marcha independiente (12-15 meses). Un niño de 8 meses que ya se sienta está en la transición perfecta hacia el gateo.

Tema: PEDIATRÍA / CRECIMIENTO Y DESARROLLO

Subtema: DENTICIÓN INFANTIL

Dificultad: Baja

Caso clínico (Corto):

Madre acude a consulta preocupada porque su hijo de 7 meses aún no presenta ninguna pieza dentaria visible. El niño está sano y no presenta otras alteraciones.

Pregunta 1

¿Cuál es el grupo de dientes que suelen ser los primeros en hacer erupción en la dentición primaria y a qué edad promedio ocurre esto?

A) Caninos superiores; 12 meses

B) Incisivos centrales inferiores; 6 a 8 meses *

C) Molares primarios; 4 meses

D) Incisivos laterales superiores; 10 meses

Retroalimentación:

La dentición primaria (de leche) inicia generalmente entre los 6 y 8 meses de vida con los incisivos centrales inferiores. Se considera dentición tardía si no hay piezas después de los 13 meses. El orden suele ser: incisivos centrales, laterales, primeros molares, caninos y segundos molares.

[Image of tooth eruption chart primary teeth]

Tema: PEDIATRÍA / RECIÉN NACIDO SANO

Subtema: EVALUACIÓN DE EDAD GESTACIONAL (CAPURRO Y BALLARD)

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Se atiende parto de neonato de quien se desconoce la fecha de última regla (FUM). Tras la estabilización, el pediatra evalúa: formación de la oreja (pabellón totalmente incurvado), tamaño de la glándula mamaria (palpable >10 mm), formación del pezón (diámetro >7.5 mm, areola punteada y levantada), textura de la piel (gruesa, grietas profundas) y pliegues plantares (surcos en más de la mitad anterior).

Pregunta 1

¿Qué escala de valoración clínica es la más adecuada para este neonato de término sin compromiso neurológico y cuál es la constante que se suma al puntaje total para obtener las semanas de gestación?

A) Escala de Silverman-Andersen; constante de 10

B) Test de Capurro; constante de 204 *

C) Test de Ballard; constante de 120

D) Escala de Apgar; constante de 40

Retroalimentación:

El Test de Capurro (versión A) evalúa 5 parámetros somáticos y es el estándar para neonatos sanos o sin daño neurológico. La fórmula es: (Puntaje total + 204) / 7. El Test de Ballard se prefiere en prematuros extremos o neonatos con compromiso neurológico/sedación ya que incluye criterios neuromusculares.

Tema: PEDIATRÍA / CRECIMIENTO Y DESARROLLO

Subtema: DESARROLLO PUBERAL (ESCALA DE TANNER)

Dificultad: Media

Caso clínico (Corto):

Paciente femenina de 11 años es llevada a consulta por presentar "un bulto" doloroso debajo del pezón derecho. A la exploración física se aprecia elevación del pecho y papila en forma de pequeño montículo, con aumento del diámetro de la areola bilateralmente. No hay vello púbico presente.

Pregunta 1

De acuerdo con la clasificación de Tanner para el desarrollo mamario (Telarquia), ¿en qué estadio se encuentra esta paciente y cuál es usualmente el primer signo de pubertad en las niñas?

A) Tanner I (Prepuberal); Aparición de vello axilar

B) Tanner II (Botón mamario); Telarquia *

C) Tanner III (Mayor elevación); Menarquia

D) Tanner IV (Doble montículo); Pubarquia

Retroalimentación:

El estadio Tanner II de telarquia se caracteriza por la aparición del botón mamario (elevación de mama y pezón). En las niñas, el primer signo clínico de pubertad suele ser la telarquia (Tanner II), seguido de la pubarquia (vello) y finalmente la menarquia (2 años después de la telarquia). En los niños, el primer signo es el aumento del volumen testicular (>4 ml).

Tema: PEDIATRÍA / NUTRICIÓN

Subtema: LACTANCIA MATERNA (PROPIEDADES Y TIPOS)

Dificultad: Baja

Caso clínico (Corto):

Madre primigesta acude a consulta de puerperio a los 4 días del parto. Refiere que la leche que le sale es de color amarillento, espesa y en poca cantidad, y le preocupa que no sea suficiente para nutrir a su bebé.

Pregunta 1

¿Cómo se denomina este tipo de leche producida en los primeros 5 días postparto y cuál es su principal característica inmunológica que la hace invaluable para el neonato?

A) Leche de transición; Alto contenido de grasa

B) Calostro; Alta concentración de Inmunoglobulina A (IgA) secretora *

C) Leche madura; Alta concentración de lactosa

D) Leche pretérmino; Alta concentración de vitamina K

Retroalimentación:

El calostro es la leche de los primeros 5 días. Su volumen es bajo (adecuado a la capacidad gástrica del neonato), pero es extremadamente rico en proteínas, vitaminas liposolubles y, sobre todo, en IgA secretora, que confiere protección inmunológica directa a la mucosa intestinal del recién nacido.

Tema: PEDIATRÍA / NUTRICIÓN

Subtema: CONTRAINDICACIONES DE LA LACTANCIA MATERNA

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Femenina de 24 años, con diagnóstico de infección por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) detectado durante el tercer trimestre del embarazo, acude para asesoría sobre la alimentación de su recién nacido. Ella desea amamantar.

Pregunta 1

De acuerdo con las recomendaciones de la NOM y las guías nacionales en México, ¿cuál es la conducta a seguir respecto a la lactancia materna en una madre con VIH?

A) Permitir la lactancia si la carga viral es indetectable

B) Lactancia mixta (seno materno y fórmula) para diluir el riesgo

C) Contraindicación absoluta de la lactancia materna; indicar sucedáneos de la leche *

D) Permitir la lactancia solo durante los primeros 6 meses

Retroalimentación:

En México, la infección por VIH en la madre es una contraindicación ABSOLUTA para la lactancia materna, debido al riesgo de transmisión vertical a través de la leche. Otras contraindicaciones absolutas incluyen: virus de la leucemia humana de células T (HTLV I y II), lesiones activas de Herpes Simple en el pezón, Galactosemia en el lactante y consumo de drogas de abuso.

Tema: PEDIATRÍA / NUTRICIÓN

Subtema: DESNUTRICIÓN PROTEICO-CALÓRICA (KWASHIORKOR)

Dificultad: Media

Caso clínico (Corto):

Lactante de 18 meses es llevado a consulta. Vive en condiciones de pobreza extrema y su dieta se basa casi exclusivamente en papillas de maíz y agua (alta en carbohidratos, baja en proteínas). A la exploración presenta edema generalizado (anasarca), abdomen globoso, hepatomegalia y lesiones en la piel tipo "pintura descascarada". Su cabello es quebradizo y presenta franjas de distinto color (signo de la bandera).

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico clínico de este tipo de desnutrición y cuál es la causa fisiopatológica del edema?

A) Marasmo; Gasto energético basal aumentado

B) Kwashiorkor; Disminución de la presión oncótica por hipoalbuminemia severa *

C) Escorbuto; Déficit de vitamina C

D) Raquitismo; Déficit de vitamina D y calcio

Retroalimentación:

El Kwashiorkor es la desnutrición proteica (clásica del niño que es destetado cuando nace un hermano). El edema se debe a la falta de aminoácidos para sintetizar albúmina, lo que disminuye la presión oncótica y causa fuga de líquido al tercer espacio. El signo de la bandera y la piel descascarada son muy característicos.

Tema: PEDIATRÍA / NUTRICIÓN

Subtema: DESNUTRICIÓN PROTEICO-CALÓRICA (MARASMO)

Dificultad: Baja

Caso clínico (Corto):

Lactante de 10 meses presenta emaciación severa. Se observa una pérdida extrema de tejido adiposo y muscular, con piel pegada al hueso, cara de "viejito" o "simiesca". No presenta edema. Se documenta una deficiencia crónica y global de todos los nutrientes (calorías y proteínas).

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico y cuál es el parámetro antropométrico que mejor define la desnutrición aguda según la OMS?

A) Marasmo; Peso para la Talla (P/T) bajo *

B) Kwashiorkor; Talla para la Edad (T/E) baja

C) Marasmo; Peso para la Edad (P/E) bajo

D) Sobrepeso; IMC para la edad elevado

Retroalimentación:

El Marasmo es una desnutrición por deficiencia calórica total (hambre crónica). El indicador Peso/Talla mide desnutrición AGUDA o "emaciación". El indicador Talla/Edad mide desnutrición CRÓNICA o "desmedro" (stunting). El Peso/Edad es un indicador global, pero no diferencia entre agudo y crónico.

Tema: PEDIATRÍA / NUTRICIÓN

Subtema: SÍNDROME DE REALIMENTACIÓN

Dificultad: Alta

Caso clínico (Corto):

Se inicia apoyo nutricional intensivo en un paciente con desnutrición grave. A las 48 horas de iniciado el soporte, el paciente presenta arritmias cardiacas, debilidad muscular extrema y datos de insuficiencia cardiaca congestiva.

Pregunta 1

¿Cuál es el disturbio electrolítico principal que caracteriza al Síndrome de Realimentación y que explica estas complicaciones?

A) Hiperpotasemia

B) Hipofosfatemia severa *

C) Hipercalcemia

D) Hiponatremia dilucional

Retroalimentación:

Al reintroducir glucosa en un desnutrido, se libera insulina, lo que provoca el paso masivo de electrolitos al interior de la célula (shift intracelular). El fósforo es el más afectado, causando hipofosfatemia severa, lo que impide la formación de ATP, llevando a falla multiorgánica y arritmias. También hay hipopotasemia e hipomagnesemia.

Tema: PEDIATRÍA / PATOLOGÍA RESPIRATORIA

Subtema: EPIGLOTITIS AGUDA

Dificultad: Alta

Caso clínico (Medio):

Preescolar de 4 años, con esquema de vacunación incompleto, es traído por fiebre alta, aspecto tóxico y dificultad respiratoria progresiva. Al examen físico, el niño se encuentra en posición de "trípode" (sentado, inclinado hacia adelante con la boca abierta), presenta sialorrea (babeo) y ausencia de tos perruna. Se observa gran ansiedad y estridor inspiratorio leve.

Pregunta 1

Ante la sospecha de epiglotitis, ¿cuál es la conducta inicial más importante para evitar el colapso de la vía aérea y qué signo radiológico es característico en la proyección lateral de cuello?

A) Realizar laringoscopia directa en el consultorio; Signo de la aguja

B) Asegurar la vía aérea en quirófano (intubación) y evitar agitar al niño; Signo del pulgar *

C) Tomar exudado faríngeo; Signo de la torre

D) Administrar micronebulizaciones con adrenalina; Signo de la doble burbuja

Retroalimentación:

La epiglotitis es una emergencia médica. El agente clásico es Haemophilus influenzae tipo b (en niños no vacunados). El manejo inicial es NO AGITAR al niño (no intentar ver la garganta con abatelenguas) y asegurar la vía aérea preferentemente en quirófano. Radiológicamente se observa el "signo del pulgar" (epiglotis edematosa).

Tema: PEDIATRÍA / PATOLOGÍA RESPIRATORIA

Subtema: BRONQUIOLITIS OBLITERANTE

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Lactante de 5 meses de edad, acude en temporada invernal por cuadro de 3 días de evolución con rinorrea y estornudos, que hoy progresa a tos, taquipnea (65 rpm), sibilancias espiratorias bilaterales y retracción intercostal. Es su primer episodio de sibilancias. Se documenta saturación de 88% al aire ambiente.

Pregunta 1

¿Cuál es el agente etiológico más común de la bronquiolitis y cuál es el tratamiento de soporte inicial más adecuado según la GPC?

A) Virus Sincitial Respiratorio (VSR); Oxígeno suplementario, aseos nasales e hidratación *

B) Adenovirus; Antibióticos macrólidos

C) Metaneumovirus; Salbutamol nebulizado de rutina

D) Virus de la Influenza; Oseltamivir

Retroalimentación:

La bronquiolitis es el primer episodio de sibilancias en un niño <2 años, precedido por un cuadro viral. El VSR es el responsable en el 80% de los casos. El tratamiento es principalmente de soporte (oxígeno para mantener SatO2 >90-92% y control de secreciones). La GPC actual no recomienda el uso rutinario de salbutamol, esteroides o antibióticos.

[Image of bronchiolitis pathophysiology diagram]

Tema: PEDIATRÍA / PATOLOGÍA RESPIRATORIA

Subtema: NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD (NAC)

Dificultad: Media

Caso clínico (Corto):

Escolar de 7 años acude por fiebre alta, escalofríos y tos productiva con dolor torácico tipo pleurítico. A la auscultación se detecta síndrome de condensación pulmonar (estertores crepitantes y soplo tubárico) localizado en la base derecha.

Pregunta 1

¿Cuál es el agente bacteriano más común en esta edad y cuál es el tratamiento de primera elección ambulatorio?

A) Mycoplasma pneumoniae; Eritromicina

B) Streptococcus pneumoniae; Amoxicilina a dosis altas *

C) Staphylococcus aureus; Dicloxacilina

D) Klebsiella pneumoniae; Ceftriaxona

Retroalimentación:

El neumococo (S. pneumoniae) sigue siendo la causa bacteriana número 1 de neumonía típica en todos los grupos de edad pediátrica. El tratamiento de elección en pacientes que pueden manejarse de forma ambulatoria es Amoxicilina (80-90 mg/kg/día) para cubrir la posible resistencia parcial del neumococo.

Tema: PEDIATRÍA / PATOLOGÍA RESPIRATORIA

Subtema: NEUMONÍA ATÍPICA

Dificultad: Media

Caso clínico (Corto):

Adolescente de 14 años con cuadro de 2 semanas de evolución caracterizado por tos seca persistente, febrícula, cefalea y malestar general. En la radiografía de tórax se observan infiltrados intersticiales bilaterales difusos que parecen "peores" de lo que el examen físico sugiere.

Pregunta 1

¿Cuál es el agente etiológico más probable de esta "neumonía atípica" y cuál es el tratamiento indicado?

A) Streptococcus pneumoniae; Penicilina

B) Mycoplasma pneumoniae; Claritromicina o Azitromicina *

C) Bordetella pertussis; Vacunación DPT

D) Chlamydia trachomatis; Ceftriaxona

Retroalimentación:

Mycoplasma pneumoniae es la causa más común de neumonía atípica en escolares mayores y adolescentes. Se caracteriza por una disociación clínico-radiológica (mucho daño en la placa, pocos hallazgos a la auscultación). Los betalactámicos no funcionan porque Mycoplasma carece de pared celular; el tratamiento de elección son los macrólidos.

Tema: PEDIATRÍA / INFECCIOSAS

Subtema: TOS FERINA (SÍNDROME COQUELUCHOIDE)

Dificultad: Alta

Caso clínico (Corto):

Lactante de 3 meses con esquema de vacunación incompleto. Presenta accesos de tos paroxística, cianozante, que terminan en un "gallo" inspiratorio y a menudo con vómito tras la tos. En la biometría hemática destaca leucocitosis importante con linfocitosis absoluta.

Pregunta 1

¿Cuál es el agente causal y cuál es el tratamiento de elección para el paciente y sus contactos cercanos para reducir la transmisibilidad?

A) Bordetella pertussis; Azitromicina *

B) Haemophilus influenzae; Amoxicilina

C) Corynebacterium diphtheriae; Antitoxina

D) Mycoplasma pneumoniae; Doxiciclina

Retroalimentación:

La Tos Ferina es causada por Bordetella pertussis. La linfocitosis es un dato muy característico. El tratamiento con macrólidos (Azitromicina es el de elección por menos efectos GI) es efectivo para eliminar la bacteria de la nasofaringe y limitar el contagio si se inicia en la fase catarral o temprana de la paroxística.

Tema: PEDIATRÍA / INFECTOLOGÍA

Subtema: SARAMPIÓN

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Escolar de 6 años, sin antecedentes de vacunación (padres antivacunas), presenta cuadro de 4 días de fiebre alta (39.5°C), tos intensa, coriza y conjuntivitis con fotofobia. Al explorar la mucosa bucal, se observan pequeñas manchas blancas con halo eritematoso frente a los molares. 24 horas después, aparece un exantema maculopapular rojo intenso que inicia detrás de las orejas y se extiende de forma cefalocaudal.

Pregunta 1

¿Cómo se denominan las lesiones en la mucosa bucal descritas y cuál es la complicación neurológica tardía (años después) más temida de esta infección?

A) Manchas de Forchheimer; Encefalitis aguda

B) Manchas de Koplik; Panencefalitis esclerosante subaguda (PEES) *

C) Lengua en fresa; Glomerulonefritis

D) Herpangina; Parálisis flácida

Retroalimentación:

Las Manchas de Koplik son patognomónicas del sarampión en la fase prodrómica. La complicación más común es la otitis media, pero la causa más frecuente de muerte

es la neumonía (células gigantes de Warthin-Finkeldey). La PEES es una complicación degenerativa cerebral que ocurre años después del cuadro agudo.

Tema: PEDIATRÍA / INFECTOLOGÍA

Subtema: ESCARLATINA

Dificultad: Media

Caso clínico (Corto):

Escolar de 5 años presenta fiebre, dolor de garganta y un exantema que se siente como "papel de lija" al tacto. A la exploración, se observan líneas rojas en los pliegues del codo (Líneas de Pastia) y una lengua con papilas prominentes de color rojo intenso (lengua en fresa). El exantema respeta el triángulo nasolabial (Facies de Filatov).

Pregunta 1

¿Cuál es el agente etiológico responsable de la producción de la toxina eritrogénica en esta enfermedad y cuál es el tratamiento de elección?

A) Staphylococcus aureus; Dicloxacilina

B) Streptococcus pyogenes (Grupo A); Penicilina V o Amoxicilina *

C) Virus de la Rubéola; Sintomático

D) Parvovirus B19; Inmunoglobulina

Retroalimentación:

La Escarlatina es causada por el Estreptococo betahemolítico del grupo A. Sus signos clave para el ENARM son: exantema en "lija", líneas de Pastia, triángulo de Filatov y lengua en fresa. El tratamiento antibiótico es fundamental para prevenir la fiebre reumática.

Tema: PEDIATRÍA / INFECTOLOGÍA

Subtema: ERITEMA INFECCIOSO (QUINTA ENFERMEDAD)

Dificultad: Baja

Caso clínico (Corto):

Preescolar de 4 años que acude a guardería, es llevado por presentar un eritema brillante y súbito en ambas mejillas, dándole un aspecto de "niño abofeteado". No presenta fiebre ni ataque al estado general. Días después aparece un exantema con patrón de "encaje" en tronco y extremidades.

Pregunta 1

¿Cuál es el agente causal y qué complicación grave puede presentar un paciente con antecedente de anemia hemolítica (ej. drepanocitosis) al infectarse con este virus?

A) Virus Herpes 6; Convulsiones febriles

B) Parvovirus B19; Crisis aplásica transitoria *

C) Coxsackie A16; Miocarditis

D) Virus de la Varicela; Ataxia cerebelosa

Retroalimentación:

El Parvovirus B19 causa el eritema infeccioso (signo de la bofetada). El virus tiene tropismo por los precursores eritroides en la médula ósea. En personas sanas no pasa nada, pero en pacientes con anemias hemolíticas crónicas puede detener la producción de glóbulos rojos, causando una crisis aplásica grave.

Tema: PEDIATRÍA / INFECTOLOGÍA

Subtema: EXANTEMA SÚBITO (ROSEOLA / SEXTA ENFERMEDAD)

Dificultad: Media

Caso clínico (Corto):

Lactante de 10 meses presenta fiebre muy alta (40°C) de 3 días de evolución, sin foco aparente, pero el niño se mantiene relativamente activo. Al cuarto día, la fiebre desaparece súbitamente y, de forma simultánea, aparece un exantema rosado maculopapular en el tronco que dura apenas 24-48 horas.

Pregunta 1

¿Cuál es el agente causal más frecuente y cuál es la complicación aguda más común durante la fase febril?

A) Virus Herpes Humano 6; Crisis convulsivas febriles *

B) Virus de la Influenza; Neumonía

C) Adenovirus; Conjuntivitis

D) Virus de la Rubéola; Artritis

Retroalimentación:

El exantema súbito (roséola) es clásico de lactantes. Lo más característico es que el exantema aparece justo cuando la fiebre se quita. Debido a la rapidez del ascenso térmico, las crisis convulsivas febriles son la complicación más frecuente en urgencias.

Tema: PEDIATRÍA / INFECTOLOGÍA

Subtema: VARICELA

Dificultad: Media

Caso clínico (Corto):

Paciente de 3 años con fiebre leve y exantema muy pruriginoso. A la exploración se observan lesiones en diferentes estadios de evolución: máculas, pápulas, vesículas ("gotas de rocío") y costras, todas presentes al mismo tiempo (patrón en "cielo estrellado").

Pregunta 1

¿Cuál es el periodo de contagio de la varicela y qué fármaco está ABSOLUTAMENTE contraindicado para el manejo de la fiebre por el riesgo de Síndrome de Reye?

A) Desde las costras hasta 10 días después; Ibuprofeno

B) Desde 2 días antes del exantema hasta que todas las lesiones son costra; Aspirina (Ácido acetilsalicílico) *

C) Solo mientras hay vesículas; Paracetamol

D) Durante todo el periodo de incubación; Metamizol

Retroalimentación:

El patrón polimórfico (cielo estrellado) es diagnóstico de varicela. El contagio inicia antes de que salgan las manchas y termina hasta que la ÚLTIMA lesión es costra. Nunca se debe dar aspirina en infecciones virales (especialmente varicela e influenza) por el riesgo de falla hepática y encefalopatía (Sx de Reye).

Tema: PEDIATRÍA / GASTROENTEROLOGÍA

Subtema: ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (ROTAVIRUS)

Dificultad: Baja

Caso clínico (Corto):

Lactante de 14 meses, con esquema de vacunación incompleto, presenta cuadro de 48 horas de evolución con vómitos iniciales, seguidos de numerosas evacuaciones

líquidas, abundantes, sin sangre ni moco, y fiebre de 38.2°C. En la guardería hay varios niños con síntomas similares.

Pregunta 1

¿Cuál es el agente etiológico más probable de diarrea grave y deshidratación en niños menores de 2 años a nivel mundial y cuál es la principal medida preventiva?

A) Escherichia coli enterotoxigénica; Lavado de manos

B) Rotavirus; Vacunación a los 2, 4 y 6 meses *

C) Salmonella typhi; Cocción de alimentos

D) Shigella sonnei; Uso de antibióticos profilácticos

Retroalimentación:

El Rotavirus es la causa principal de diarrea grave en lactantes. La vacuna (monovalente o pentavalente) ha reducido drásticamente la mortalidad. El cuadro clínico típico es vómito, fiebre y diarrea acuosa que puede llevar rápidamente a la deshidratación.

Tema: PEDIATRÍA / GASTROENTEROLOGÍA

Subtema: DESHIDRATACIÓN Y PLANES DE REHIDRATACIÓN (OMS)

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Lactante de 10 meses con diarrea acuosa. A la exploración física: ojos hundidos, llanto sin lágrimas, mucosa oral seca, signo del lienzo (turgencia de la piel disminuida) que retorna lentamente (< 2 segundos) y el niño se muestra muy sediento e irritable. El llenado capilar es de 2 segundos.

Pregunta 1

De acuerdo con la clasificación de la OMS/GPC, ¿en qué grado de deshidratación se encuentra el paciente y cuál es el manejo indicado (Plan de Hidratación)?

A) Sin deshidratación; Plan A (en el hogar)

B) Deshidratación moderada; Plan B (Vida Suero Oral 100 ml/kg en 4 horas) *

C) Deshidratación grave (choque); Plan C (Líquidos IV)

D) Deshidratación leve; Plan A con antibióticos

Retroalimentación:

El paciente presenta datos de "algún grado de deshidratación" (sed, irritabilidad, ojos hundidos). Esto indica el inicio del Plan B: administración de Vida Suero Oral (VSO) a dosis de 50-100 ml/kg durante 4 horas en la unidad médica, ofreciendo a cucharaditas o sorbos frecuentes. Si el niño no tolera la vía oral, se puede usar sonda nasogástrica (gastrocclisis).

Tema: PEDIATRÍA / GASTROENTEROLOGÍA

Subtema: ESTENOSIS HIPERTRÓFICA DEL PÍLORO (EHP)

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Recién nacido masculino de 3 semanas de vida. La madre refiere que desde hace 3 días presenta vómitos después de cada toma de leche. Los vómitos son de contenido lácteo (no biliosos), proyectivos ("en proyectil") y el niño se muestra con mucha hambre después de vomitar. A la exploración física se palpa una masa firme de 2 cm en el epigastrio (oliva pilórica).

Pregunta 1

¿Cuál es el trastorno ácido-base y electrolítico clásico esperado en este paciente y cuál es el estudio de imagen de primera elección?

A) Acidosis metabólica hiperclorémica; Radiografía simple

B) Alcalosis metabólica hipoclorémica e hipopotasémica; Ultrasonido abdominal *

C) Acidosis respiratoria compensada; Serie esofagogastroduodenal

D) Alcalosis respiratoria; Tomografía computarizada

Retroalimentación:

La pérdida de ácido clorhídrico por el vómito gástrico produce alcalosis metabólica con cloro bajo. El potasio baja porque el riñón intenta ahorrar protones (H+) a cambio de excretar potasio. El ultrasonido es el estándar de oro, buscando un grosor del músculo pilórico >4 mm o una longitud >17 mm.

Tema: PEDIATRÍA / GASTROENTEROLOGÍA

Subtema: INVAGINACIÓN INTESTINAL (INTUSUSCEPCIÓN)

Dificultad: Alta

Caso clínico (Medio):

Lactante de 8 meses, previamente sano, presenta cuadros súbitos de dolor abdominal paroxístico (el niño encoge las piernas y llora inconsolablemente), alternados con periodos de letargo. Hace una hora presentó una evacuación con aspecto de "jalea de grosella" (sangre y moco). A la palpación se detecta una masa alargada en forma de "salchicha" en el hipocondrio derecho.

Pregunta 1

¿Cuál es la localización más frecuente de la invaginación y cuál es el método diagnóstico y terapéutico inicial en casos no complicados?

A) Ileo-ileal; Cirugía de urgencia (procedimiento de Ladd)

B) Ileo-cólica; Colon por enema (hidrostático o neumático) *

C) Yeyuno-ileal; Observación y ayuno

D) Colo-cólica; Colonoscopia de urgencia

Retroalimentación:

La invaginación ileocólica es la causa más común de obstrucción intestinal entre los 3 meses y 3 años. La "jalea de grosella" es un signo tardío de isquemia mucosa. El colon por enema (con aire o bario) es diagnóstico (signo del muelle o resorte) y terapéutico, ya que la presión puede reducir la invaginación en el 80% de los casos si no hay perforación.

Tema: PEDIATRÍA / GASTROENTEROLOGÍA

Subtema: REFLUJO GASTROESOFÁGICO (RGE) VS ENFERMEDAD (ERGE)

Dificultad: Baja

Caso clínico (Corto):

Lactante de 4 meses que presenta regurgitaciones frecuentes después de comer. El niño tiene una curva de crecimiento normal (buen peso y talla), no presenta irritabilidad, síntomas respiratorios ni anemia. La madre está muy angustiada por los vómitos.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta recomendada según la GPC?

A) ERGE patológica; Iniciar Omeprazol y ranitidina

B) Reflujo Gastroesofágico funcional (Regurgitador feliz); Medidas posturales y tranquilidad a los padres *

C) Acalasia; Miotomía de Heller

D) Alergia a la proteína de la leche de vaca; Cambio a fórmula de aminoácidos

Retroalimentación:

El "regurgitador feliz" es un lactante sano que crece bien a pesar del reflujo, el cual es fisiológico por la inmadurez del esfínter esofágico inferior. No requiere fármacos ni estudios invasivos; solo medidas como fraccionar la dieta y posición supina al dormir (nunca prono por riesgo de muerte súbita).

Tema: PEDIATRÍA / NEFROLOGÍA

Subtema: INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS (IVU)

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Lactante femenina de 8 meses presenta fiebre de 39°C de 24 horas de evolución, sin foco infeccioso aparente (no hay síntomas respiratorios ni gastrointestinales). Se observa irritable y con rechazo al alimento. Se realiza recolección de orina mediante sonda vesical. El examen general de orina (EGO) muestra nitritos positivos y esterasa leucocitaria positiva.

Pregunta 1

¿Cuál es el agente etiológico más común y cuál es el estándar de oro para confirmar el diagnóstico de IVU en este grupo de edad?

A) Staphylococcus saprophyticus; Examen General de Orina

B) Escherichia coli; Urocultivo (obtenido por sonda o punción suprapúbica) *

C) Proteus mirabilis; Ultrasonido renal

D) Klebsiella pneumoniae; Hemocultivo

Retroalimentación:

E. coli causa el 80-90% de las IVU en pediatría. En lactantes, la fiebre sin foco obliga a descartar IVU. El diagnóstico definitivo SIEMPRE requiere urocultivo. Para evitar

contaminación en niños que no controlan esfínteres, la GPC recomienda el cateterismo vesical (punto de corte >10,000 UFC/ml) o punción suprapúbica (cualquier crecimiento es positivo).

Tema: PEDIATRÍA / UROLOGÍA

Subtema: REFLUJO VESICOURETERAL (RVU)

Dificultad: Media

Caso clínico (Corto):

Lactante masculino de 10 meses con antecedente de dos episodios de IVU febriles confirmadas por cultivo. El ultrasonido renal reporta dilatación de los uréteres y de la pelvis renal bilateral.

Pregunta 1

¿Cuál es el estudio de imagen de elección para el diagnóstico y clasificación del Reflujo Vesicoureteral y cuál es la complicación a largo plazo más importante si no se trata?

A) Tomografía computarizada; Litiasis renal

B) Cistouretrografía miccional cistoscópica (CUM); Cicatrices renales e hipertensión arterial *

C) Gammagrama renal con DMSA; Quistes renales

D) Resonancia magnética; Hidronefrosis prenatal

Retroalimentación:

La CUM (VCUG por sus siglas en inglés) es el estudio estándar para diagnosticar y graduar el RVU (Grados I-V). El RVU permite que las bacterias asciendan al riñón,

causando pielonefritis recurrente que deja cicatrices renales, lo cual es una causa importante de hipertensión arterial y enfermedad renal crónica en la infancia.

Tema: PEDIATRÍA / NEFROLOGÍA

Subtema: SÍNDROME NEFRÓTICO (CAMBIOS MÍNIMOS)

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Escolar de 4 años acude por presentar edema bipalpebral y de extremidades inferiores que ha progresado a anasarca en una semana. El niño no tiene antecedentes de faringitis previa. Laboratorios: Proteinuria masiva (relación proteína/creatinina en orina >2), Albúmina sérica de 1.8 g/dl (hipoalbuminemia) y Colesterol total de 300 mg/dl (hiperlipidemia). Presión arterial normal y sedimento urinario sin eritrocitos.

Pregunta 1

¿Cuál es la causa más probable de síndrome nefrótico en este rango de edad y cuál es el tratamiento de primera línea?

A) Glomerulonefritis postestreptocócica; Penicilina

B) Enfermedad de Cambios Mínimos; Prednisona (Esteroides) *

C) Nefropatía por IgA; Ciclofosfamida

D) Lupus Eritematoso Sistémico; Micofenolato

Retroalimentación:

La Enfermedad de Cambios Mínimos es la causa de >90% de los síndromes nefróticos en preescolares. Se caracteriza por la tríada: Edema, Proteinuria masiva e Hipoalbuminemia. La gran mayoría responde de forma excelente a los esteroides

(corticosensibles), por lo que no se requiere biopsia renal de entrada a menos que sea corticorresistente.

Tema: PEDIATRÍA / NEFROLOGÍA

Subtema: SÍNDROME NEFRÍTICO (POSTESTREPTOCÓCICO)

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Escolar de 8 años acude por presentar orina color "refresco de cola" (hematuria macroscópica), edema leve en párpados y disminución del volumen urinario (oliguria). La madre refiere que hace 2 semanas el niño tuvo una infección de garganta con fiebre. A la exploración física se detecta Presión Arterial de 130/90 mmHg (hipertensión para su edad).

Pregunta 1

¿Cuál es la causa más probable de este cuadro y qué hallazgo en los niveles de complemento sérico esperaría encontrar?

A) Glomerulonefritis postestreptocócica; Disminución de C3 y C4 normal *

B) Nefrosis lipoidea; Niveles de C3 normales

C) Púrpura de Henoch-Schönlein; C3 elevado

D) Síndrome de Alport; C4 disminuido

Retroalimentación:

El síndrome nefrítico se caracteriza por Hematuria, Hipertensión, Edema y Oliguria. La causa postestreptocócica ocurre tras un periodo de latencia (1-3 semanas tras faringitis o 3-6 semanas tras infección cutánea/impétigo). El hallazgo inmunológico típico es el consumo de la vía alterna del complemento (C3 bajo con C4 normal).

Tema: PEDIATRÍA / UROLOGÍA

Subtema: CRIPTORQUIDIA

Dificultad: Baja

Caso clínico (Corto):

Lactante de 6 meses acude a revisión de niño sano. A la exploración de los genitales, no se palpa el testículo derecho en la bolsa escrotal; se logra palpar en el canal inguinal pero no se puede descender manualmente al escroto.

Pregunta 1

¿A partir de qué edad se considera que el descenso espontáneo es improbable y se debe referir a cirugía para orquidopexia, con el fin de disminuir el riesgo de infertilidad y cáncer testicular?

A) 3 meses

B) 6 meses *

C) 2 años

D) 5 años

Retroalimentación:

La mayoría de los testículos descienden en los primeros 3 a 4 meses de vida. Si después de los 6 meses el testículo no ha descendido (criptorquidia verdadera), la probabilidad de descenso espontáneo es mínima. La GPC recomienda realizar la orquidopexia quirúrgica entre los 6 y 12 meses de edad (máximo 18 meses) para preservar la función de las células germinales.

Tema: PEDIATRÍA / HEMATOLOGÍA

Subtema: ANEMIA FERROPÉNICA

Dificultad: Baja

Caso clínico (Medio):

Lactante de 14 meses es traído a consulta por palidez de tegumentos y falta de apetito. Como antecedente de importancia, el niño consume más de 1 litro de leche de vaca entera al día y consume muy pocos alimentos sólidos. En la biometría hemática destaca: Hemoglobina 8.5 g/dl, Volumen Corpuscular Medio (VCM) 68 fL (microcitosis), HCM 22 pg (hipocromía) y RDW (amplitud de distribución eritrocitaria) elevado.

Pregunta 1

¿Cuál es la causa más probable de la anemia en este paciente y cuál es el marcador bioquímico más sensible para diagnosticar la deficiencia de hierro en estadios tempranos?

A) Deficiencia de Vitamina B12; Niveles de ácido fólico

B) Anemia Ferropénica por dieta pobre en hierro; Ferritina sérica disminuida *

C) Talasemia minor; Electroforesis de hemoglobina

D) Intoxicación por plomo; Punteado basófilo en frotis

Retroalimentación:

La anemia ferropénica es la causa más común de anemia nutricional en pediatría, frecuentemente asociada al consumo excesivo de leche de vaca (que tiene baja biodisponibilidad de hierro y puede causar microsangrados intestinales). La ferritina sérica es el primer parámetro que se altera (refleja los depósitos de reserva). El RDW elevado ayuda a diferenciarla de la Talasemia (donde el RDW suele ser normal).

[Image of iron deficiency anemia blood smear microcytosis and hypochromia]

Tema: PEDIATRÍA / HEMATOLOGÍA

Subtema: PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA INMUNE (PTI)

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Escolar de 6 años que hace 2 semanas presentó un cuadro de infección respiratoria superior. Hoy acude por la aparición súbita de petequias y equimosis en extremidades y tronco, sin antecedentes de trauma. No presenta fiebre, hepatomegalia ni adenopatías. Laboratorios: Plaquetas de 15,000/mm^3, Hemoglobina y Leucocitos normales. Frotis de sangre periférica confirma trombocitopenia con plaquetas de tamaño aumentado.

Pregunta 1

¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico de esta enfermedad y cuál es el tratamiento de primera línea si el paciente presenta sangrado mucocutáneo activo?

A) Destrucción de plaquetas mediada por anticuerpos (IgG); Inmunoglobulina IV o Corticosteroides *

B) Deficiencia de Factor VIII; Plasma fresco congelado

C) Producción insuficiente de plaquetas en médula ósea; Transfusión de plaquetas inmediata

D) Agregación plaquetaria excesiva; Aspirina

Retroalimentación:

La PTI es la causa más común de trombocitopenia aislada en niños, precedida a menudo por una infección viral. El diagnóstico es de exclusión (líneas roja y blanca normales). El tratamiento se indica generalmente si las plaquetas son <20,000 o hay sangrado importante. La primera línea son los esteroides (prednisona) o la inmunoglobulina humana (IGIV). Se debe evitar la transfusión de plaquetas a menos que haya hemorragia que comprometa la vida.

Tema: PEDIATRÍA / ONCOLOGÍA

Subtema: LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA (LLA)

Dificultad: Alta

Caso clínico (Largo):

Preescolar de 4 años presenta cuadro de 3 semanas de evolución con fatiga, fiebre persistente, dolor óseo que le impide caminar y aparición de moretones sin causa aparente. A la exploración física se detecta palidez intensa, linfadenopatías cervicales y axilares, y hepatosplenomegalia franca (hígado a 4 cm y bazo a 5 cm debajo del borde costal). Biometría hemática: Hb 6 g/dl, Plaquetas 30,000/mm^3, Leucocitos 50,000/mm^3 con presencia de un 80% de células inmaduras (blastos).

Pregunta 1

¿Cuál es el estudio definitivo para confirmar el diagnóstico de LLA y cuál es el factor pronóstico citogenético de "buen pronóstico" más característico?

A) Biopsia de ganglio linfático; Presencia de Cromosoma Filadelfia

B) Aspirado de Médula Ósea (con >20-25% de blastos); Hiperdiploidía o translocación t(12;21) *

C) Tomografía por emisión de positrones (PET); Hipodiploidía

D) Mieloperoxidasa positiva en blastos; Translocación t(9;22)

Retroalimentación:

La LLA es el cáncer infantil más frecuente (pico 2-5 años). El diagnóstico requiere aspirado de médula ósea. La t(12;21) [TEL-AML1] confiere un excelente pronóstico, mientras que el cromosoma Filadelfia t(9;22) es de mal pronóstico. La clínica de falla

medular (anemia, trombocitopenia, fiebre) + infiltración (dolor óseo, organomegalia) es el cuadro "de libro".

Tema: PEDIATRÍA / ONCOLOGÍA

Subtema: TUMOR DE WILMS (NEFROBLASTOMA)

Dificultad: Media

Caso clínico (Corto):

Lactante de 3 años es llevado a consulta porque la madre notó una masa en el abdomen mientras lo bañaba. El niño se encuentra asintomático. A la palpación se detecta una masa firme, lisa, que no cruza la línea media en el flanco izquierdo. Se documenta hipertensión arterial leve.

Pregunta 1

¿Cuál es la neoplasia renal más común en la infancia y cuál es la asociación sindrómica clásica conocida como WAGR?

A) Neuroblastoma; Asociado a diarrea acuosa

B) Tumor de Wilms; Wilms, Aniridia, Malformaciones Genitourinarias y Retraso mental *

C) Teratoma; Asociado a pubertad precoz

D) Adenocarcinoma renal; Asociado a tabaquismo pasivo

Retroalimentación:

El Tumor de Wilms es el tumor renal primario más común. A diferencia del neuroblastoma, el Wilms suele ser una masa que NO cruza la línea media y el paciente suele estar en buen estado general. La hipertensión se debe a la producción

de renina por el tumor. El síndrome WAGR es una deleción en el cromosoma 11 (gen WT1).

Tema: PEDIATRÍA / HEMATOLOGÍA

Subtema: HEMOFILIA

Dificultad: Media

Caso clínico (Corto):

Paciente masculino de 2 años presenta aumento de volumen, calor y dolor intenso en la rodilla derecha tras una caída leve. Tiene antecedentes de sangrado prolongado tras la circuncisión. Laboratorios: Tiempo de Protrombina (TP) normal, Tiempo de Tromboplastina Parcial activada (TTPa) muy prolongado que corrige al mezclar con plasma normal.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico más probable y cuál es la deficiencia específica en la Hemofilia A?

A) Enfermedad de Von Willebrand; Déficit de adhesión plaquetaria

B) Hemofilia A; Deficiencia del Factor VIII *

C) Hemofilia B; Deficiencia del Factor IX

D) Trombastenia de Glanzmann; Deficiencia de GpIIb/IIIa

Retroalimentación:

La Hemofilia A (Factor VIII) y B (Factor IX) son trastornos ligados al cromosoma X (afectan varones). La hemartrosis (sangrado en articulaciones) es el signo clínico característico. El TTPa prolongado indica alteración en la vía intrínseca de la coagulación. El tratamiento consiste en la reposición del factor faltante.

Tema: PEDIATRÍA / NEUROLOGÍA

Subtema: CRISIS CONVULSIVAS FEBRILES

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Lactante de 18 meses es traído a urgencias tras presentar un episodio de movimientos tónico-clónicos generalizados de 3 minutos de duración, asociado a un pico febril de 39.4°C secundario a otitis media. Tras el evento, el niño presenta un periodo postictal breve de 5 minutos y recupera su estado de alerta normal. Es la primera vez que ocurre y no hay antecedentes familiares de epilepsia.

Pregunta 1

De acuerdo con la GPC, ¿cómo se clasifica esta crisis febril y cuál es la conducta terapéutica y diagnóstica a seguir?

A) Crisis febril compleja; Realizar punción lumbar de rutina y dejar tratamiento con fenitoína

B) Crisis febril simple; Manejo del foco infeccioso, antipiréticos y tranquilidad a los padres *

C) Status epilepticus febril; Iniciar impregnación con valproato de magnesio

D) Epilepsia mioclónica; Solicitar electroencefalograma (EEG) urgente

Retroalimentación:

Una crisis febril simple es: 1) Generalizada, 2) Dura <15 min, 3) No se repite en 24h y 4) Recuperación ad integrum. Según la GPC "Diagnóstico y Manejo de Crisis Convulsivas Febriles", no se recomienda punción lumbar (a menos que haya signos meníngeos), ni EEG, ni TAC de rutina. El riesgo de desarrollar epilepsia es casi igual al de la población general (~1-2%).

Tema: PEDIATRÍA / NEUROLOGÍA

Subtema: MENINGITIS BACTERIANA AGUDA

Dificultad: Alta

Caso clínico (Largo):

Lactante de 7 meses con esquema de vacunación incompleto (falta Pentavalente y Neumococo). Inicia con fiebre, irritabilidad, vómito en proyectil y abombamiento de la fontanela anterior. A la exploración se encuentra rigidez de nuca y signos de Kernig y Brudzinski positivos. Se sospecha meningitis y se planea punción lumbar.

Pregunta 1

¿Cuáles son los agentes causales más frecuentes en este grupo de edad (2 meses a 5 años) en México y cuál es el tratamiento antibiótico empírico de elección según la GPC?

A) S. agalactiae y L. monocytogenes; Ampicilina + Gentamicina

B) S. pneumoniae y N. meningitidis; Cefotaxima o Ceftriaxona + Vancomicina *

C) E. coli y Klebsiella; Amikacina + Cefalotina

D) H. influenzae únicamente; Cloranfenicol

Retroalimentación:

Tras la introducción de la vacuna conjugada contra Hib, Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis son los líderes. La GPC recomienda el uso de cefalosporinas de 3ra generación (Cefotaxima o Ceftriaxona) asociadas a Vancomicina (por la resistencia neumocócica). Nota: Se debe administrar Dexametasona 15-20 min antes o junto con la primera dosis de antibiótico para reducir el riesgo de hipoacusia por H. influenzae.

Tema: PEDIATRÍA / NEUROLOGÍA

Subtema: EPILEPSIA (AUSENCIAS TÍPICAS)

Dificultad: Media

Caso clínico (Corto):

Escolar de 7 años es referido por su maestra debido a que presenta múltiples episodios al día donde "se queda ido" por 5 a 10 segundos, interrumpiendo su actividad y sin perder el tono postural. No recuerda lo sucedido. El EEG muestra un patrón de punta-onda lenta de 3 Hz, generalizado y simétrico.

Pregunta 1

¿Cuál es el tratamiento de elección inicial para las crisis de ausencia según la GPC mexicana?

A) Carbamazepina

B) Valproato de Magnesio (o Etosuximida) *

C) Fenobarbital

D) Levetiracetam

Retroalimentación:

Las ausencias típicas son clásicas de la edad escolar. El patrón de 3 Hz es patognomónico. El tratamiento de elección es el Valproato de Magnesio o la Etosuximida. Ojo: La Carbamazepina está contraindicada en ausencias porque puede empeorar las crisis.

Tema: PEDIATRÍA / NEUROLOGÍA

Subtema: DEFECTOS DEL TUBO NEURAL

Dificultad: Baja

Caso clínico (Corto):

Recién nacido de madre que no cursó con control prenatal ni tomó suplementos de ácido fólico. Presenta una tumoración en la región lumbosacra que contiene líquido cefalorraquídeo, meninges y raíces nerviosas expuestas, sin cobertura de piel. Se observa parálisis de extremidades inferiores.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico específico de este defecto y cuál es la medida de prevención primaria más costo-efectiva recomendada por la GPC?

A) Meningocele; Suplementación con vitamina C

B) Mielomeningocele; Ácido fólico 0.4 mg/día (general) o 4 mg/día (alto riesgo) *

C) Espina bífida oculta; Suplementación con yodo

D) Encefalocele; Cesárea programada

Retroalimentación:

El mielomeningocele es la forma más grave de espina bífida quística. La prevención es clave: 0.4 mg de ácido fólico al día en toda mujer en edad fértil (mínimo 3 meses antes del embarazo) y 4 mg en mujeres con antecedente previo de hijo con DTN.

Tema: PEDIATRÍA / NEUROLOGÍA

Subtema: HIDROCEFALIA / MALFORMACIÓN DE CHIARI

Dificultad: Media

Caso clínico (Corto):

Lactante de 4 meses con crecimiento acelerado del perímetro cefálico (por encima del percentil 95). A la exploración: fontanela tensa, diástasis de suturas craneales y "signo del sol poniente" (desviación de la mirada hacia abajo). La RM muestra descenso de las amígdalas cerebelosas a través del foramen magno.

Pregunta 1

¿Cuál es la asociación más probable en este caso y cuál es el tratamiento definitivo para la hidrocefalia obstructiva?

A) Malformación de Chiari tipo II; Derivación Ventrículo-Peritoneal (DVP) *

B) Síndrome de West; Vigabatrina

C) Craneosinostosis; Resección de suturas

D) Hidranencefalia; Soporte únicamente

Retroalimentación:

La hidrocefalia en lactantes se manifiesta por macrocefalia y signos de hipertensión endocraneana. El signo del sol poniente es muy característico. La malformación de Chiari tipo II (descenso de amígdalas y tallo) se asocia casi siempre a mielomeningocele e hidrocefalia. El tratamiento estándar es la colocación de una válvula de derivación (DVP).

Tema: PEDIATRÍA / URGENCIAS

Subtema: INGESTIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Lactante de 2 años es traído a urgencias porque hace una hora la madre lo encontró jugando con una caja de herramientas y sospecha que tragó una "pila de botón". El niño se encuentra asintomático, sin dificultad respiratoria ni sialorrea. Se realiza radiografía de tórax y abdomen, localizando el objeto circular en el esófago medio, con el signo del "doble contorno" o "halo".

Pregunta 1

De acuerdo con la GPC, ¿cuál es la conducta inmediata indicada ante el hallazgo de una batería de botón alojada en el esófago, incluso si el paciente está asintomático?

A) Observar por 24 horas para ver si progresa al estómago

B) Extracción endoscópica de urgencia (antes de 2 horas) *

C) Administrar laxantes para favorecer su expulsión rectal

D) Inducir el vómito con jarabe de ipecacuana

Retroalimentación:

Las baterías de botón en esófago son una EMERGENCIA quirúrgica/endoscópica debido al riesgo de necrosis por licuefacción y perforación esofágica en tan solo 2 horas (por la descarga eléctrica y fuga de electrolito). El signo del "doble contorno" en la Rx es clave para diferenciarla de una moneda. Si la pila ya estuviera en el estómago y el niño fuera asintomático, se podría observar, pero en esófago SIEMPRE se saca de inmediato.

Tema: PEDIATRÍA / URGENCIAS

Subtema: INGESTIÓN DE CÁUSTICOS

Dificultad: Alta

Caso clínico (Medio):

Preescolar de 3 años ingiere accidentalmente un producto de limpieza (desengrasante de estufa, base de hidróxido de sodio). Presenta dolor intenso, sialorrea y rechazo a la deglución. En urgencias, los padres intentan darle leche para "neutralizar".

Pregunta 1

¿Cuál de las siguientes acciones está ABSOLUTAMENTE CONTRAINDICADA según la GPC y cuál es el tiempo ideal para realizar la endoscopia diagnóstica para clasificar el daño (Escala de Zargar)?

A) Contraindicado: Inducir el vómito o neutralizar con líquidos; Endoscopia entre las 6 y 24 horas *

B) Contraindicado: Canalizar vía venosa; Endoscopia inmediata (primera hora)

C) Contraindicado: Ayuno; Endoscopia después de 48 horas

D) Contraindicado: Uso de esteroides; No realizar endoscopia si hay sialorrea

Retroalimentación:

Nunca se debe inducir el vómito (re-exposición de la mucosa al químico) ni intentar neutralizar con ácidos/bases (reacción exotérmica que quema más). La endoscopia es el estándar de oro para pronóstico, pero debe realizarse después de las 6 horas (para que la lesión sea visible) y antes de las 24-48 horas (después aumenta el riesgo de perforación por la fase de reblandecimiento).

Tema: PEDIATRÍA / URGENCIAS

Subtema: INTOXICACIÓN POR PARACETAMOL

Dificultad: Media

Caso clínico (Corto):

Escolar de 6 años ingiere accidentalmente una dosis desconocida de paracetamol de un frasco de jarabe. Acude a las 3 horas de la ingesta, se encuentra asintomático.

Pregunta 1

¿Cuál es el metabolito tóxico del paracetamol y cuál es el antídoto de elección que debe administrarse según el normograma de Rumack-Matthew?

A) N-acetil-p-benzoquinonaimina (NAPQI); N-acetilcisteína *

B) Ácido salicílico; Bicarbonato de sodio

C) Glutatión; Vitamina K

D) Amonio; Lactulosa

Retroalimentación:

El NAPQI es el metabolito altamente reactivo que agota las reservas de glutatión hepático causando necrosis. La N-acetilcisteína actúa como precursor del glutatión y es más efectiva si se administra dentro de las primeras 8 horas post-ingesta. El normograma de Rumack-Matthew ayuda a decidir el tratamiento basándose en los niveles séricos a partir de las 4 horas.

Tema: PEDIATRÍA / ACCIDENTES

Subtema: ASPIRACIÓN DE CUERPO EXTRAÑO EN VÍA AÉREA

Dificultad: Alta

Caso clínico (Medio):

Lactante de 18 meses, mientras comía cacahuates, presenta cuadro súbito de tos cianozante y asfixia que cede parcialmente. Actualmente se encuentra con sibilancias localizadas en el hemitórax derecho y disminución del murmullo vesicular en esa zona. La radiografía de tórax en espiración muestra enfisema obstructivo (atrapamiento aéreo) del lado derecho.

Pregunta 1

¿Cuál es la localización más frecuente de los cuerpos extraños aspirados en niños y cuál es el manejo definitivo?

A) Bronquio principal izquierdo; Videobroncoscopia flexible

B) Bronquio principal derecho; Broncoscopia rígida *

C) Tráquea superior; Maniobra de Heimlich repetida

D) Laringe; Intubación orotraqueal

Retroalimentación:

Debido a que el bronquio principal derecho es más ancho, corto y vertical, es el sitio más común de alojamiento. La tríada clásica es: tos súbita, disminución de ruidos respiratorios y sibilancias localizadas. El manejo de elección para extracción es la broncoscopia rígida bajo anestesia general, ya que permite un mejor control de la vía aérea y el uso de pinzas de extracción.

Tema: PEDIATRÍA / URGENCIAS

Subtema: INTOXICACIÓN POR HIERRO

Dificultad: Alta

Caso clínico (Corto):

Preescolar que ingiere suplementos de sulfato ferroso de su madre. Presenta vómitos hemáticos y dolor abdominal (Fase 1). Tras una mejoría aparente (Fase 2), desarrolla choque, acidosis metabólica y falla hepática (Fase 3). En la radiografía de abdomen se observan múltiples tabletas radiopacas.

Pregunta 1

¿Cuál es el antídoto quelante específico indicado en la intoxicación grave por hierro (niveles >500 mg/dl)?

A) Edetato de calcio disódico

B) Deferoxamina *

C) Penicilamina

D) Azul de metileno

Retroalimentación:

La Deferoxamina es el quelante específico para el hierro. Se une al hierro férrico circulante formando ferrioxamina, que se excreta por el riñón dándole a la orina un color característico de "vino malvasía" o "color naranja/rojizo".

Tema: PEDIATRÍA / ASPECTOS LEGALES Y SOCIALES

Subtema: MALTRATO INFANTIL (SÍNDROME DEL NIÑO MALTRATADO)

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Lactante de 9 meses es traído a urgencias por "caída de la cama" hace 2 horas. A la exploración física, el niño se encuentra irritable y con vómito. Se observan equimosis en diferentes estadios de evolución en espalda y glúteos, así como una quemadura circular pequeña en la planta del pie. La tomografía de cráneo revela un hematoma subdural y la serie ósea muestra fracturas en "asa de balde" (metafisiarias) y fracturas costales posteriores.

Pregunta 1

Ante la sospecha de maltrato físico (específicamente Síndrome del Niño Sacudido), ¿cuál es el hallazgo oftalmológico clásico que confirma el mecanismo de aceleración-desaceleración y cuál es la obligación legal del médico según la NOM-046?

A) Catarata congénita; Avisar solo si los padres lo autorizan

B) Hemorragias retinianas (multicapa); Notificación inmediata al Ministerio Público *

C) Conjuntivitis química; Dar de alta con vigilancia

D) Glaucoma de ángulo abierto; Realizar estudio socioeconómico privado

Retroalimentación:

La tríada del niño sacudido incluye: Hematoma subdural, Edema cerebral y Hemorragias retinianas. Las fracturas costales posteriores y metafisiarias son altamente sugestivas de maltrato. Según la NOM-046-SSA2-2005, el personal de salud debe dar aviso al Ministerio Público ante cualquier sospecha de lesiones por violencia familiar o maltrato.

Tema: PEDIATRÍA / INFECTOLOGÍA NEONATAL

Subtema: SEPSIS NEONATAL TEMPRANA

Dificultad: Alta

Caso clínico (Medio):

Recién nacido de 12 horas de vida presenta inestabilidad térmica (hipotermia), rechazo a la vía oral y taquicardia. Antecedentes: Madre con ruptura prematura de membranas de 24 horas, fiebre intraparto y líquido amniótico fétido. Laboratorios: Leucopenia (<5,000), neutropenia y Proteína C Reactiva elevada.

Pregunta 1

¿Cuál es el agente etiológico más común de sepsis neonatal temprana en México y cuál es el esquema antibiótico empírico de elección según la GPC?

A) Staphylococcus aureus; Dicloxacilina + Amikacina

B) Streptococcus agalactiae (Grupo B) y E. coli; Ampicilina + Gentamicina *

C) Listeria monocytogenes; Vancomicina

D) Pseudomonas aeruginosa; Ceftazidima

Retroalimentación:

La sepsis temprana (primeras 72 horas) suele ser por transmisión vertical. Los patógenos más frecuentes son el Estreptococo del grupo B y E. coli. El tratamiento de

primera línea es la combinación de un betalactámico (Ampicilina) para cubrir Gram positivos y Listeria, más un aminoglucósido (Gentamicina) para Gram negativos.

Tema: PEDIATRÍA / INFECTOLOGÍA

Subtema: CHOQUE SÉPTICO EN PEDIATRÍA

Dificultad: Alta

Caso clínico (Corto):

Escolar de 8 años con sospecha de foco infeccioso abdominal, presenta fiebre, taquicardia, llenado capilar de 4 segundos, pulsos débiles y alteración del estado de conciencia. Se inicia reanimación hídrica agresiva.

Pregunta 1

De acuerdo con las guías de "Sobreviviendo a la Sepsis" en pediatría, ¿cuál es el volumen inicial de cristaloides (bolos) recomendado para la expansión de volumen y cuál es el inotrópico de elección en caso de choque "frío" (resistente a líquidos)?

A) 10 ml/kg; Dopamina

B) 20 ml/kg; Adrenalina (Epinefrina) *

C) 50 ml/kg; Noradrenalina

D) 5 ml/kg; Dobutamina

Retroalimentación:

La reanimación inicial consiste en bolos de cristaloides de 20 ml/kg. Si el choque persiste (choque frío: llenado capilar retardado, pulsos débiles), la Adrenalina es el fármaco de elección actual por encima de la dopamina. En choque "caliente" (llenado capilar rápido, pulsos saltones) se prefiere la Noradrenalina.

Tema: PEDIATRÍA / VACUNACIÓN

Subtema: VACUNA SRP (TRIPLE VIRAL)

Dificultad: Baja

Caso clínico (Corto):

Madre acude con su hijo de 12 meses de edad para la aplicación de las vacunas correspondientes. El niño ya cuenta con el esquema previo completo (Hexavalente, Rotavirus, Neumococo).

Pregunta 1

¿Qué vacuna debe recibir por primera vez a los 12 meses según el esquema nacional de México y a qué edad se aplica el refuerzo según la actualización más reciente (2023)?

A) Triple Viral (SRP); Refuerzo a los 18 meses *

B) DPT; Refuerzo a los 4 años

C) Pentavalente; Refuerzo a los 2 años

D) Influenza; Refuerzo anual

Retroalimentación:

La vacuna SRP (Sarampión, Rubéola, Parotiditis) se aplica a los 12 meses.
Importante: El esquema actual en México marca el refuerzo a los 18 meses de edad (anteriormente era a los 6 años). Es un cambio reciente que el ENARM suele preguntar para evaluar actualización.

Tema: PEDIATRÍA / ORTOPEDIA PEDIÁTRICA

Subtema: DISPLASIA DEL DESARROLLO DE LA CADERA (DDC)

Dificultad: Media

Caso clínico (Corto):

Recién nacida femenina, producto de presentación pélvica. A la exploración física se aprecia asimetría de pliegues en muslos. Se realizan maniobras de exploración de cadera.

Pregunta 1

¿Cuál es la maniobra que detecta la luxación de la cadera (reducción del fémur al acetábulo) y cuál es el estudio de imagen de elección en menores de 4 meses?

A) Maniobra de Barlow; Radiografía AP de pelvis

B) Maniobra de Ortolani; Ultrasonido de cadera *

C) Signo de Trendelenburg; Tomografía

D) Maniobra de Galeazzi; Resonancia Magnética

Retroalimentación:

Ortolani "entra" (reduce la cadera luxada), Barlow "sale" (luxa la cadera reducible). En menores de 4 meses, debido a que la cabeza del fémur no se ha osificado, el estudio de elección es el Ultrasonido (Ángulos de Graf). Después de los 4 meses se prefiere la Radiografía.

Tema: PEDIATRÍA / ORTOPEDIA

Subtema: ENFERMEDAD DE LEGG-CALVÉ-PERTHES

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Escolar masculino de 6 años presenta cojera (claudicación) de inicio insidioso y dolor leve en la región inguinal que se irradia a la rodilla derecha de 2 meses de evolución. A la exploración física, presenta limitación para la abducción y rotación interna de la

cadera derecha. No tiene antecedente de fiebre ni traumatismo reciente. El paciente es de talla baja para su edad.

Pregunta 1

¿Cuál es la fisiopatología de esta enfermedad y qué hallazgo radiológico inicial es característico en la proyección de Lauenstein (posición de rana)?

A) Inflamación sinovial transitoria; Engrosamiento de la cápsula

B) Necrosis avascular de la cabeza femoral; Signo de la "uñada" o fractura subcondral *

C) Desplazamiento de la epífisis; Línea de Klein alterada

D) Infección bacteriana del hueso; Reacción perióstica

Retroalimentación:

La enfermedad de Legg-Calvé-Perthes es una necrosis avascular idiopática de la epífisis femoral superior. Es típica en varones de 4 a 8 años. El diagnóstico es radiológico, observando mayor densidad de la cabeza femoral, aplanamiento o el signo del "viento en popa" (fractura subcondral). El tratamiento busca mantener la esfericidad de la cabeza femoral.

Tema: PEDIATRÍA / ORTOPEDIA

Subtema: EPIFISIOLISIS FEMORAL PROXIMAL

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Adolescente de 13 años con obesidad grado I (IMC en percentil 97) acude por dolor crónico en el muslo izquierdo y rodilla, de 3 semanas de evolución, que empeora con la actividad física. Al caminar, el paciente mantiene el pie izquierdo en rotación

externa. A la exploración, al flexionar la cadera, esta se desvía obligatoriamente a la rotación externa (Signo de Drehmann).

Pregunta 1

¿Cuál es el manejo definitivo inmediato para evitar la progresión del deslizamiento epifisario según la GPC?

A) Reposo absoluto y observación

B) Fijación in situ con un tornillo canulado *

C) Reducción cerrada y yeso tipo spica

D) Reemplazo total de cadera

Retroalimentación:

La epifisiolisis es el desplazamiento de la epífisis sobre la metáfisis a través del cartílago de crecimiento. Es la causa más común de cojera en el adolescente obeso. El dolor en la rodilla es un dolor referido clásico que suele confundir al clínico. El tratamiento SIEMPRE es quirúrgico para estabilizar la fisis y evitar la necrosis avascular o la condrolisis.

Tema: PEDIATRÍA / REUMATOLOGÍA

Subtema: PÚRPURA DE HENOCH-SCHÖNLEIN (VASCULITIS POR IgA)

Dificultad: Media

Caso clínico (Largo):

Preescolar de 5 años presenta exantema papular eritematoso que progresa a púrpura palpable, localizado simétricamente en glúteos y extremidades inferiores. Se acompaña de dolor abdominal tipo cólico y artralgias en tobillos. El examen general

de orina muestra hematuria microscópica. El recuento de plaquetas y tiempos de coagulación son normales.

Pregunta 1

¿Cuál es la tríada clínica clásica de esta vasculitis y cuál es la complicación gastrointestinal aguda más grave que debe vigilarse?

A) Fiebre, anemia y púrpura; Vólvulo

B) Púrpura palpable, artralgias y dolor abdominal; Invaginación intestinal (ileo-ileal) *

C) Trombocitopenia, falla renal y anemia; Perforación gástrica

D) Edema, proteinuria e hipertensión; Infarto esplénico

Retroalimentación:

La Púrpura de Henoch-Schönlein es la vasculitis más común en la infancia. Se caracteriza por el depósito de complejos inmunes de IgA. Un dato clave para el ENARM es que las plaquetas son NORMALES (a diferencia de la PTI). El dolor abdominal puede preceder al exantema y la complicación quirúrgica más frecuente es la invaginación intestinal, típicamente ileo-ileal.

Tema: PEDIATRÍA / REUMATOLOGÍA

Subtema: ENFERMEDAD DE KAWASAKI

Dificultad: Alta

Caso clínico (Medio):

Lactante de 2 años presenta fiebre de 39°C de 6 días de evolución que no cede con antipiréticos. A la exploración destaca: inyección conjuntival bilateral no exudativa, labios fisurados y eritematosos ("lengua en fresa"), exantema polimorfo en tronco, edema en manos y pies, y una adenopatía cervical unilateral de 2 cm.

Pregunta 1

¿Cuál es la complicación más grave de esta vasculitis de medianos vasos y cuál es el tratamiento de elección para prevenirla según la GPC?

A) Insuficiencia renal; Esteroides a dosis altas

B) Aneurismas coronarios; Inmunoglobulina IV (2 g/kg) + Aspirina *

C) Glomerulonefritis; Ciclofosfamida

D) Estenosis pilórica; Cirugía

Retroalimentación:

La Enfermedad de Kawasaki es una vasculitis sistémica que afecta predominantemente a menores de 5 años. El diagnóstico es clínico (Fiebre ≥5 días + 4 de los 5 criterios clásicos). La complicación temida son los aneurismas coronarios (25% si no hay tratamiento). La IGIV administrada antes del día 10 de fiebre reduce este riesgo al <5%.

Tema: PEDIATRÍA / REUMATOLOGÍA

Subtema: ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL (AIJ) SISTÉMICA

Dificultad: Alta

Caso clínico (Corto):

Escolar de 7 años presenta picos febriles diarios (>39°C) de 2 semanas de duración, acompañados de un exantema evanescente (que va y viene) de color salmón en tronco. A la exploración se encuentra hepatoesplenomegalia y artritis en muñecas. Laboratorios muestran leucocitosis, trombocitosis y ferritina muy elevada.

Pregunta 1

¿Cómo se denomina históricamente a esta variante de AIJ y qué complicación potencialmente mortal se asocia a niveles extremadamente altos de ferritina?

A) Enfermedad de Still; Síndrome de Activación Macrofágica (SAM) *

B) Enfermedad de Lyme; Bloqueo auriculoventricular

C) Artritis reumatoide juvenil; Amiloidosis

D) Fiebre reumática; Carditis

Retroalimentación:

La AIJ sistémica (Enfermedad de Still) se distingue por el predominio de síntomas extraarticulares (fiebre, exantema salmón, organomegalia). El SAM es una complicación grave caracterizada por una "tormenta de citocinas", citopenias, disfunción hepática y ferritina >10,000 ng/ml.

Tema: PEDIATRÍA / ENDOCRINOLOGÍA

Subtema: HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO

Dificultad: Alta

Caso clínico (Medio):

Recién nacido de 15 días de vida es traído a consulta tras reporte de tamiz neonatal metabólico sospechoso. A la exploración física destaca fontanela posterior amplia (>1 cm), ictericia prolongada, piel seca, macroglosia y una hernia umbilical reducible. La madre refiere que el niño es "muy tranquilo" y tiene estreñimiento.

Pregunta 1

De acuerdo con la GPC, ¿cuál es la causa más frecuente de esta patología a nivel mundial y cuál es la meta de tiempo para iniciar el tratamiento con Levotiroxina para evitar el retraso mental irreversible?

A) Deficiencia de yodo; Iniciar antes de los 3 meses

B) Disgenesia tiroidea (Ectopia #1); Iniciar antes de los 15 días de vida *

C) Dishormonogénesis; Iniciar al mes de vida

D) Hipotiroidismo hipofisario; Iniciar a los 60 días

Retroalimentación:

El hipotiroidismo congénito es la causa más común de retraso mental prevenible. En México y el mundo, la disgenesia tiroidea (siendo la ectopia la más frecuente) es la causa principal. La GPC "Diagnóstico y Tratamiento del Hipotiroidismo Congénito" enfatiza que el tratamiento con Levotiroxina (10-15 mcg/kg/día) debe iniciarse idealmente antes de los 15 días de vida para asegurar un neurodesarrollo normal.

Tema: PEDIATRÍA / ENDOCRINOLOGÍA

Subtema: DIABETES MELLITUS TIPO 1 (DM1)

Dificultad: Media

Caso clínico (Largo):

Escolar de 9 años acude a urgencias por presentar cuadro de 24 horas con dolor abdominal, náuseas y vómito. La madre refiere que en las últimas 2 semanas el niño ha bajado de peso a pesar de tener mucha hambre, orina frecuentemente (incluso en la noche) y toma mucha agua. A la exploración: deshidratación moderada, respiración rápida y profunda (Kussmaul) y aliento con olor a frutas (cetónico). Laboratorios: Glucosa 350 mg/dl, pH 7.15, HCO3 12 mEq/L, cetonuria (+++).

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico inicial y cuál es la primera medida terapéutica que dicta la GPC antes de iniciar la infusión de insulina?

A) Estado hiperosmolar; Administración de bicarbonato

B) Cetoacidosis Diabética (CAD); Rehidratación con solución salina al 0.9% (20 ml/kg) *

C) Apendicitis aguda; Cirugía de urgencia

D) Hipoglucemia reactiva; Glucosa IV

Retroalimentación:

La CAD es a menudo la forma de debut de la DM1 en niños. La tríada diagnóstica es: Glucosa >200, pH <7.3 o HCO3 <15, y cetonemia/cetonuria. El manejo inicial SIEMPRE es la expansión de volumen con solución isotónica. La insulina (0.1 U/kg/hr) se inicia una hora después de haber comenzado la hidratación, siempre y cuando el potasio sea >3.3 mEq/L.

Tema: PEDIATRÍA / ENDOCRINOLOGÍA

Subtema: TALLA BAJA (VARIANTES NORMALES)

Dificultad: Media

Caso clínico (Corto):

Escolar de 10 años acude por talla baja. Se encuentra por debajo del percentil 3 para su edad. Sus padres son de estatura promedio. Al realizar la Edad Ósea (Radiografía de mano no dominante), esta reporta 7 años (retrasada respecto a la edad cronológica). El niño no ha iniciado caracteres sexuales secundarios.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico más probable de esta variante normal del crecimiento y cuál es el pronóstico de talla final?

A) Talla baja familiar; Talla final baja

B) Retraso Constitucional del Crecimiento y la Pubertad (RCCP); Talla final acorde al potencial genético *

C) Deficiencia de Hormona de Crecimiento; Talla final muy baja

D) Síndrome de Turner; Requiere cariotipo

Retroalimentación:

El RCCP se caracteriza por: 1) Edad ósea retrasada respecto a la cronológica, 2) Velocidad de crecimiento normal (pero en percentiles bajos), y 3) Pubertad tardía. Al final, estos niños "dan el estirón" más tarde pero alcanzan su talla blanco familiar. En la Talla Baja Familiar, la edad ósea coincide con la edad cronológica.

Tema: PEDIATRÍA / ENDOCRINOLOGÍA

Subtema: HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA (HSC)

Dificultad: Alta

Caso clínico (Corto):

Recién nacido de 10 días de vida presenta cuadro de deshidratación grave, vómito y pérdida de peso importante. Laboratorios reportan: Hiponatremia severa, Hiperpotasemia y Acidosis metabólica. Al revisar los genitales se observa ambigüedad genital (hipertrofia de clítoris y fusión de labios mayores).

Pregunta 1

¿Cuál es la deficiencia enzimática más común en la HSC y qué metabolito se encuentra elevado en el tamiz neonatal para su diagnóstico?

A) 11-beta-hidroxilasa; Desoxicortisol

B) 21-alfa-hidroxilasa; 17-hidroxiprogesterona *

C) 17-alfa-hidroxilasa; Pregnenolona

D) 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa; DHEA

Retroalimentación:

La deficiencia de 21-hidroxilasa causa el 95% de los casos de HSC. La forma "perdedora de sal" es una urgencia neonatal por el déficit de cortisol y aldosterona, lo que explica la hiponatremia e hiperpotasemia. El exceso de andrógenos causa la virilización en niñas. El diagnóstico se confirma con niveles elevados de 17-OHP.

Tema: PEDIATRÍA / ENDOCRINOLOGÍA

Subtema: PUBERTAD PRECOZ

Dificultad: Media

Caso clínico (Corto):

Niña de 7 años presenta aparición de vello púbico y telarquia (botón mamario) Tanner II. La madre refiere que la niña ha crecido mucho en el último año. La edad ósea está adelantada (9 años).

Pregunta 1

De acuerdo con la GPC, ¿cómo se define la pubertad precoz en niñas y cuál es el estudio inicial para diferenciar entre origen central y periférico?

A) Aparición de caracteres antes de los 8 años; Determinación de LH basal o tras estímulo con GnRH *

B) Aparición de caracteres antes de los 10 años; Ultrasonido pélvico

C) Antes de los 9 años; Niveles de cortisol

D) Antes de los 7 años; Resonancia de silla turca

Retroalimentación:

Pubertad precoz es antes de los 8 años en niñas y 9 años en niños. La pubertad precoz CENTRAL es dependiente de gonadotropinas (LH/FSH elevadas). El

tratamiento de elección para la forma central son los análogos de GnRH de acción prolongada para frenar la maduración ósea y evitar el cierre prematuro de las epífisis.

Tema: PEDIATRÍA / INFECTOLOGÍA

Subtema: PARASITOSIS INTESTINAL (GIARDIASIS)

Dificultad: Media

Caso clínico (Largo):

Preescolar de 4 años acude a guardería. Presenta cuadro de 3 semanas de evolución con evacuaciones disminuidas de consistencia, esteatorreicas (grasosas, fétidas, flotan en el agua), acompañadas de distensión abdominal, flatulencia y pérdida de peso ponderal. No presenta sangre ni moco en las heces.

Pregunta 1

¿Cuál es el agente etiológico más probable y cuál es el estudio diagnóstico inicial de elección según la GPC?

A) Entamoeba histolytica; Coproantígeno

B) Giardia lamblia (duodenalis); Coproparasitoscópico en serie de tres (CPS) *

C) Ascaris lumbricoides; Radiografía de abdomen

D) Cryptosporidium; Tinción de Kinyoun

Retroalimentación 1:

La Giardiasis es la parasitosis intestinal patógena más común en niños. El trofozoíto se adhiere a la mucosa del duodeno causando malabsorción (esteatorrea). El estándar inicial es el CPS seriado para buscar quistes o trofozoítos.

Pregunta 2

De acuerdo con la Guía de Práctica Clínica, ¿cuál es el tratamiento de primera línea para la Giardiasis en pediatría?

A) Metronidazol (15-30 mg/kg/día por 5-7 días) *

B) Albendazol (dosis única)

C) Nitazoxanida (solo en mayores de 12 años)

D) TMP/SMX

Retroalimentación 2:

El Metronidazol sigue siendo el fármaco de elección en las GPC mexicanas por su eficacia y bajo costo. La Tinidazola o Nitazoxanida son alternativas aceptables.

Tema: PEDIATRÍA / INFECTOLOGÍA

Subtema: ENTEROBIASIS (OXIUROS)

Dificultad: Baja

Caso clínico (Corto):

Escolar de 6 años presenta prurito anal de predominio nocturno muy intenso, lo que le provoca insomnio e irritabilidad. La madre refiere haber visto "pequeños hilos blancos" moviéndose en la región perianal del niño mientras dormía.

Pregunta 1

¿Cuál es el método diagnóstico de elección (estándar de oro) para confirmar esta parasitosis?

A) Coproparasitoscópico seriado

B) Prueba de Graham (cinta adhesiva perianal) *

C) Biometría hemática (buscando eosinofilia)

D) Cultivo de heces

Retroalimentación 1:

Enterobius vermicularis no pone huevos en las heces, sino en los pliegues perianales durante la noche. Por ello, el CPS suele ser negativo y la prueba de la cinta adhesiva (Graham) por la mañana es el método diagnóstico correcto.

Pregunta 2

¿Cuál es la recomendación terapéutica fundamental para evitar la recurrencia de la infección?

A) Tratamiento solo al paciente con Mebendazol

B) Tratamiento a todos los miembros de la familia y lavado de ropa de cama con agua caliente *

C) Uso de antibióticos tópicos en la región anal

D) Dieta rica en fibra y probióticos

Retroalimentación 2:

Dada la facilidad de transmisión fecal-oral y a través de fómites (ropa, sábanas), el tratamiento familiar simultáneo es crucial para erradicar el parásito.

Tema: PEDIATRÍA / INFECTOLOGÍA

Subtema: TUBERCULOSIS PEDIÁTRICA

Dificultad: Alta

Caso clínico (Largo):

Lactante de 18 meses acude por fiebre persistente de 2 semanas, tos no productiva y falla para medrar (pérdida de peso). Antecedente de abuelo con "tos crónica" que vive en la misma casa. Se realiza prueba de PPD (Tuberculina) resultando en una induración de 12 mm a las 72 horas. La radiografía de tórax muestra linfadenopatía hiliar y un foco de consolidación (Complejo de Ghon).

Pregunta 1

¿Cuál es el criterio de positividad del PPD en un niño con contacto estrecho con un caso activo de tuberculosis?

A) > 5 mm *

B) > 10 mm

C) > 15 mm

D) Cualquier grado de induración

Retroalimentación 1:

En pediatría, un PPD se considera positivo con ≥5 mm si hay contacto estrecho con un caso bacilífero o inmunosupresión. En niños sanos sin contactos conocidos en zonas endémicas (como México), el corte suele ser ≥10 mm.

Pregunta 2

¿Cuál es el método preferido para obtener muestras para baciloscopia (BAAR) en niños pequeños que no saben expectorar?

A) Inducción de esputo con solución salina

B) Aspirado gástrico en ayuno (tres días consecutivos) *

C) Biopsia de ganglio hiliar

D) Broncoscopia de rutina

Retroalimentación 2:

Los niños suelen deglutir el esputo, por lo que el aspirado gástrico matutino es la técnica estándar para recuperar Mycobacterium tuberculosis en pacientes pediátricos.

Tema: PEDIATRÍA / INFECTOLOGÍA

Subtema: VIH EN PEDIATRÍA

Dificultad: Alta

Caso clínico (Medio):

Recién nacido de madre con diagnóstico de VIH realizado durante el parto (sin tratamiento previo). Se desea descartar la transmisión vertical en el neonato.

Pregunta 1

¿Cuál es el estudio de elección para el diagnóstico de infección por VIH en un lactante menor de 18 meses?

A) ELISA para VIH

B) Western Blot

C) Carga viral (PCR de DNA o RNA de VIH) *

D) Conteo de CD4

Retroalimentación 1:

Las pruebas de anticuerpos (ELISA/Western Blot) no sirven en menores de 18 meses porque detectan los anticuerpos maternos que cruzan la placenta. Se requiere una prueba virológica directa (PCR).

Pregunta 2

¿Cuál es la profilaxis antibiótica indicada en este lactante a partir de las 6 semanas de vida para prevenir la neumonía por Pneumocystis jirovecii?

A) Amoxicilina

B) Trimetoprima/Sulfametoxazol (TMP/SMX) *

C) Azitromicina

D) Aciclovir

Retroalimentación 2:

Todo lactante expuesto al VIH debe recibir profilaxis con TMP/SMX desde las 6 semanas hasta que se descarte la infección, debido a la alta mortalidad de la neumonía por Pneumocystis en esta población.

Tema: PEDIATRÍA / CARDIOLOGÍA

Subtema: PERSISTENCIA DEL CONDUCTO ARTERIOSO (PCA)

Dificultad: Media

Caso clínico (Largo):

Lactante femenino de 2 meses de edad, nacida prematura a las 32 semanas de gestación. La madre refiere que se cansa al succionar, presenta sudoración excesiva y falta de ganancia de peso. A la exploración física se detecta un soplo continuo, rudo, en región infraclavicular izquierda, con zumbido mecánico (maquinaria de Gibson) y pulsos periféricos saltones.

Pregunta 1

¿Cuál es el estudio de imagen de elección para confirmar el diagnóstico y evaluar la repercusión hemodinámica?

A) Radiografía de tórax

B) Ecocardiograma Doppler color *

C) Electrocardiograma

D) Cateterismo cardiaco

Retroalimentación 1:

El ecocardiograma es el estándar de oro para confirmar la PCA, permitiendo visualizar la dirección del cortocircuito (shunt) y el diámetro del conducto. La radiografía solo mostraría cardiomegalia e hiperflujo pulmonar inespecífico.

Pregunta 2

¿Cuál es el tratamiento farmacológico de primera elección indicado en neonatos pretérmino para intentar el cierre del conducto arterioso según la GPC?

A) Prostaglandina E1

B) Indometacina o Ibuprofeno (inhibidores de la COX) *

C) Furosemida

D) Digoxina

Retroalimentación 2:

En prematuros, los inhibidores de la síntesis de prostaglandinas (Indometacina, Ibuprofeno o incluso Paracetamol IV según guías recientes) son efectivos para el cierre. La Prostaglandina E1 se usa para lo contrario: mantenerlo abierto en cardiopatías ducto-dependientes.

Tema: PEDIATRÍA / CARDIOLOGÍA

Subtema: COMUNICACIÓN INTERVENTRICULAR (CIV)

Dificultad: Media

Caso clínico (Corto):

Lactante de 3 meses presenta un soplo holosistólico grado III/IV, rudo, de alta frecuencia, mejor escuchado en el tercer o cuarto espacio intercostal izquierdo, con irradiación en barra. Se detecta hiperflujo pulmonar en la radiografía.

Pregunta 1

¿Cuál es el tipo de CIV más frecuente y cuál es la evolución natural más común de las comunicaciones pequeñas (tipo Roger)?

A) CIV membranosa; Cierre espontáneo en el primer año de vida *

B) CIV muscular; Insuficiencia cardiaca progresiva

C) CIV infundibular; Endocarditis inmediata

D) CIV de entrada; Hipertensión pulmonar irreversible

Retroalimentación 1:

La CIV es la cardiopatía congénita más frecuente al nacimiento (si excluimos la válvula aórtica bicúspide). La variante membranosa es la más común. Las CIV pequeñas suelen cerrar espontáneamente sin requerir cirugía.

Tema: PEDIATRÍA / CARDIOLOGÍA

Subtema: TETRALOGÍA DE FALLOT

Dificultad: Alta

Caso clínico (Largo):

Preescolar de 2 años presenta cianosis generalizada que se acentúa al llorar o realizar esfuerzos. La madre refiere que el niño suele adoptar una posición de "acuclillamiento" para descansar. A la exploración se detecta un soplo sistólico eyectivo en foco pulmonar y un segundo ruido único. La radiografía de tórax muestra una silueta cardiaca en forma de "zapato sueco" o "bota".

Pregunta 1

¿Cuáles son los 4 componentes anatómicos de esta tetralogía?

A) CIA, Estenosis mitral, Hipertrofia VI, Cabalgamiento aórtico

B) CIV, Estenosis pulmonar (obstrucción al flujo de salida VD), Cabalgamiento de la aorta e Hipertrofia del ventrículo derecho *

C) PCA, Coartación aórtica, Estenosis tricuspídea, Situs inversus

D) Atresia pulmonar, CIV, CIA, Dextrocardia

Retroalimentación 1:

La Tetralogía de Fallot es la cardiopatía cianógena más frecuente después del primer año de vida. El grado de cianosis depende directamente de la severidad de la estenosis pulmonar.

Pregunta 2

¿Cuál es la explicación fisiopatológica de por qué el niño realiza el "acuclillamiento" durante las crisis de hipoxia?

A) Disminuye el retorno venoso sistémico

B) Aumenta las resistencias vasculares sistémicas, disminuyendo el cortocircuito derecha-izquierda *

C) Favorece la apertura de la válvula pulmonar

D) Relaja el infundíbulo ventricular

Retroalimentación 2:

Al acuclillarse, el niño aumenta la presión en las arterias femorales (resistencia sistémica), lo que obliga a que más sangre pase del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar en lugar de escapar por la CIV hacia la aorta, mejorando la oxigenación.

Tema: PEDIATRÍA / CARDIOLOGÍA

Subtema: COARTACIÓN DE LA AORTA

Dificultad: Media

Caso clínico (Corto):

Escolar de 10 años es enviado a valoración por presentar cifras tensionales de 140/90 mmHg. A la exploración física se detecta una diferencia de presión arterial entre

miembros superiores e inferiores, y pulsos femorales débiles y retardados respecto al pulso braquial.

Pregunta 1

¿Cuál es el hallazgo radiológico clásico en las costillas (signo de Roesler) secundario a la circulación colateral y con qué síndrome genético se asocia frecuentemente?

A) Erosión del borde inferior de las costillas; Síndrome de Turner *

B) Fracturas costales; Síndrome de Down

C) Costillas cervicales; Síndrome de DiGeorge

D) Tórax en quilla; Síndrome de Marfan

Retroalimentación 1:

El signo de Roesler son muescas costales producidas por la presión de las arterias intercostales dilatadas (colaterales). Hasta el 35% de las pacientes con Síndrome de Turner presentan coartación aórtica. El tratamiento de elección es la corrección quirúrgica o angioplastia.

Tema: PEDIATRÍA / CIRUGÍA NEONATAL

Subtema: ATRESIA DE ESÓFAGO

Dificultad: Media

Caso clínico (Largo):

Recién nacido de término, con antecedente materno de polihidramnios severo. A los pocos minutos del nacimiento, presenta sialorrea abundante, cianosis y dificultad respiratoria que aumenta al intentar la alimentación. Se intenta pasar una sonda orogástrica, la cual se encuentra con resistencia a los 10 cm de la arcada dental.

Pregunta 1

¿Cuál es la variedad anatómica más frecuente de la atresia de esófago y qué hallazgo en la radiografía de abdomen confirmaría su presencia?

A) Tipo I (Atresia pura); Abdomen sin gas (opaco)

B) Tipo III (Atresia distal con fístula traqueoesofágica distal); Presencia de aire en el estómago y restos de la sonda enrollada en el saco superior *

C) Tipo IV (Fístula doble); Neumotórax bilateral

D) Tipo V (Fístula en H); Gas distal normal con esófago permeable

Retroalimentación 1:

La Tipo III (clasificación de Ladd o Vogt) es la más frecuente (85%). La presencia de aire en el estómago confirma que existe una comunicación entre la vía aérea y el esófago distal (fístula). Si el abdomen estuviera "ciego" o sin gas, sospecharíamos una Tipo I (sin fístula).

[Image of types of tracheoesophageal fistula and esophageal atresia]

Pregunta 2

¿Cuál es la asociación malformativa más frecuentemente descrita en estos pacientes y que debe descartarse sistemáticamente?

A) Asociación VACTERL (Vertebrales, Anales, Cardiacas, Traqueoesofágicas, Renales y de extremidades/Limb) *

B) Síndrome de Down

C) Tríada de Currarino

D) Secuencia de Potter

Retroalimentación 2:

Hasta el 50% de los niños con atresia de esófago tienen otras malformaciones. VACTERL es la asociación clásica; las malformaciones cardiacas son las que más influyen en el pronóstico quirúrgico inmediato.

Tema: PEDIATRÍA / CIRUGÍA NEONATAL

Subtema: HERNIA DIAFRAGMÁTICA CONGÉNITA (BOCHDALEK)

Dificultad: Alta

Caso clínico (Largo):

Recién nacido de 38 semanas presenta dificultad respiratoria severa inmediata al nacer, cianosis y abdomen excavado (escafoide). A la auscultación, los ruidos cardiacos están desplazados a la derecha y se escuchan ruidos hidroaéreos en el hemitórax izquierdo.

Pregunta 1

¿Cuál es el defecto diafragmático más común y cuál es la acción de manejo inicial que está ABSOLUTAMENTE CONTRAINDICADA en este paciente?

A) Hernia de Morgagni; Contraindicado: Intubación endotraqueal

B) Hernia de Bochdalek (posterolateral izquierda); Contraindicado: Ventilación con bolsa-válvula-mascarilla *

C) Hernia hiatal; Contraindicado: Sonda orogástrica

D) Eventración diafragmática; Contraindicado: Uso de surfactante

Retroalimentación 1:

La hernia de Bochdalek es la más común (85-90% en el lado izquierdo). La ventilación con mascarilla introduce aire al estómago e intestinos herniados, comprimiendo aún más el pulmón hipoplásico y el corazón, empeorando el choque. El manejo inicial debe ser intubación inmediata y colocación de sonda orogástrica a derivación.

Pregunta 2

¿Cuál es el factor determinante principal de la alta mortalidad en estos pacientes?

A) La presencia de la fístula

B) Hipoplasia pulmonar e hipertensión pulmonar persistente *

C) Malrotación intestinal asociada

D) Sepsis neonatal

Retroalimentación 2:

Aunque el defecto sea quirúrgico, la cirugía NO es una emergencia. La prioridad es estabilizar la hipertensión pulmonar y la hipoplasia del pulmón ipsilateral (y a menudo contralateral).

Tema: PEDIATRÍA / CIRUGÍA NEONATAL

Subtema: GASTROSQUISIS VS ONFALOCELE

Dificultad: Media

Caso clínico (Corto):

Recién nacido presenta un defecto en la pared abdominal de 3 cm, localizado a la derecha del cordón umbilical. Las asas intestinales están expuestas, sin saco protector, y se observan edematosas y con restos de fibrina. El cordón umbilical está insertado normalmente a la izquierda del defecto.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico más probable y qué característica lo diferencia principalmente del onfalocele?

A) Onfalocele; El onfalocele tiene saco y la gastrosquisis no *

B) Gastrosquisis; La gastrosquisis es paraumbilical derecha y carece de saco protector *

C) Hernia umbilical; El defecto es mayor a 5 cm

D) Extrofia vesical; Se asocia a malformaciones cardiacas

Retroalimentación 1:

La gastrosquisis es un defecto paraumbilical (casi siempre derecho) sin saco. El onfalocele es un defecto central (a través del anillo umbilical) y las vísceras están cubiertas por peritoneo y amnios. La gastrosquisis suele ser un defecto aislado, mientras que el onfalocele se asocia frecuentemente a síndromes (Beckwith-Wiedemann) y malformaciones cardiacas.

Tema: PEDIATRÍA / DERMATOLOGÍA

Subtema: DERMATITIS ATÓPICA

Dificultad: Media

Caso clínico (Largo):

Lactante de 5 meses presenta lesiones eccematosas, eritematosas y con costras hemáticas en ambas mejillas, respetando el triángulo nasolabial, y en superficies extensoras de extremidades. La madre refiere que el niño está muy irritable y se frota constantemente contra las sábanas. Antecedente de madre con asma bronquial.

Pregunta 1

De acuerdo con la GPC, ¿cuál es el pilar del tratamiento a largo plazo para mantener la barrera cutánea y qué tipo de esteroide se recomienda para las exacerbaciones en la cara?

A) Baños con jabón de pasta; Esteroides de alta potencia (Clobetasol)

B) Uso de emolientes y dermolimpiadores sin jabón (Syndet); Esteroides de baja potencia (Hidrocortisona) *

C) Antibióticos tópicos; Esteroides sistémicos

D) Antihistamínicos orales únicamente; Inhibidores de calcineurina de entrada

Retroalimentación 1:

La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica. La hidratación con emolientes es la base. En cara, debido a que la piel es delgada, se deben usar esteroides de baja potencia para evitar atrofia cutánea o telangiectasias. Los antihistamínicos solo ayudan con el prurito, no curan la lesión.

Tema: PEDIATRÍA / DERMATOLOGÍA

Subtema: DERMATITIS DEL PAÑAL

Dificultad: Baja

Caso clínico (Medio):

Lactante de 8 meses presenta eritema intenso en área del pañal de 3 días de evolución. A la exploración se observa eritema confluente en "W" que respeta los pliegues inguinales. No hay lesiones satélites.

Pregunta 1

¿Cuál es la causa más probable y cuál es el manejo de primera línea según la GPC?

A) Candidiasis; Nistatina tópica

B) Dermatitis irritativa del pañal; Medidas de barrera (óxido de zinc) y dejar al aire libre *

C) Dermatitis seborreica; Ketoconazol

D) Impétigo; Mupirocina

Retroalimentación 1:

La dermatitis irritativa (por contacto con orina/heces) típicamente RESPETA los pliegues porque ahí no hay contacto directo. Si el eritema afectara pliegues y tuviera pápulas satélites, pensaríamos en Candida. El tratamiento es preventivo: cambios frecuentes de pañal y pastas de barrera.

Tema: PEDIATRÍA / INFECTOLOGÍA DERMATOLÓGICA

Subtema: IMPÉTIGO

Dificultad: Baja

Caso clínico (Corto):

Escolar de 6 años presenta lesiones alrededor de la nariz y boca que iniciaron como pequeñas vesículas y ahora son costras de color amarillento ("melicéricas"). El niño se encuentra afebril y en buen estado general.

Pregunta 1

¿Cuáles son los agentes causales más comunes y cuál es el tratamiento tópico de elección?

A) S. pyogenes y S. aureus; Mupirocina o Ácido fusídico *

B) P. aeruginosa; Neomicina

C) H. influenzae; Amoxicilina oral

D) Virus Herpes Simple; Aciclovir

Retroalimentación 1:

El impétigo no ampolloso (el más común) se caracteriza por las costras melicéricas. El tratamiento tópico es suficiente en lesiones localizadas. Si fuera extenso o ampolloso, se consideraría tratamiento sistémico (Dicloxacilina o Cefalexina).

Tema: PEDIATRÍA / OFTALMOLOGÍA

Subtema: RETINOPATÍA DEL PREMATURO (ROP)

Dificultad: Alta

Caso clínico (Medio):

Recién nacido de 29 semanas de gestación, con peso de 1,100 g al nacer. Requirió ventilación mecánica y oxígeno suplementario por 15 días. Actualmente tiene 4 semanas de vida extrauterina.

Pregunta 1

De acuerdo con la GPC mexicana, ¿cuáles son los criterios de tamizaje para ROP y en qué momento debe realizarse la primera evaluación oftalmológica en este paciente?

A) Todo RN <34 semanas o <1,750 g; Evaluar a las 4 semanas de vida o 31 semanas corregidas *

B) Solo RN <28 semanas; Evaluar al nacimiento

C) RN con asfixia neonatal; Evaluar a los 6 meses

D) RN <2,500 g; Evaluar al egreso hospitalario

Retroalimentación 1:

El tamizaje es crucial para prevenir la ceguera. Se debe evaluar a todo niño ≤34 semanas de gestación o ≤1,750 g, o aquellos con factores de riesgo (oxigenoterapia prolongada). La primera evaluación se hace a la 4ta semana de vida o a la 31 semana postconcepcional.

Tema: PEDIATRÍA / OFTALMOLOGÍA

Subtema: ESTRABISMO Y LEUCOCORIA

Dificultad: Media

Caso clínico (Corto):

Lactante de 12 meses es llevado por los padres porque notan que "desvía el ojo izquierdo hacia adentro" de forma constante. Al realizar el reflejo rojo, este es normal en ambos ojos. El test de Hirschberg muestra el reflejo luminoso desplazado hacia la parte temporal de la córnea izquierda.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico clínico y cuál es la complicación más importante a evitar (ojo vago)?

A) Exotropía; Catarata

B) Endotropía (Esotropía); Ambliopía *

C) Retinoblastoma; Glaucoma

D) Pseudovisión; Astigmatismo

Retroalimentación 1:

La endotropía es la desviación hacia adentro. El test de Hirschberg es la herramienta básica de tamizaje. La ambliopía (falta de desarrollo de la agudeza visual por falta de uso del ojo desviado) es la complicación que debe tratarse con parches o cirugía antes de los 6-7 años, cuando termina la plasticidad visual.

Tema: PEDIATRÍA / URGENCIAS

Subtema: REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP) PEDIÁTRICA

Dificultad: Alta

Caso clínico (Largo):

Se encuentra en el área de urgencias cuando traen a un lactante de 8 meses inconsciente tras un evento de atragantamiento. Al evaluar, el niño no respira y no se palpa pulso braquial. Usted se encuentra solo en ese momento.

Pregunta 1

De acuerdo con las guías de la AHA/GPC, ¿cuál es la relación de compresión-ventilación indicada para un solo reanimador en pediatría y cuál es la profundidad recomendada de las compresiones?

A) 30:2; Al menos un tercio del diámetro AP del tórax (aprox. 4 cm) *

B) 15:2; 5 cm

C) 3:1; 2 cm

D) 30:2; 6 cm

Retroalimentación 1:

Para un solo reanimador (lego o profesional), la relación siempre es 30:2 para simplificar. Si hubiera dos reanimadores profesionales, la relación cambia a 15:2. La profundidad en lactantes debe ser de aproximadamente 4 cm (1.5 pulgadas) o un tercio del diámetro del tórax.

Pregunta 2

Si tras iniciar maniobras y conectar el monitor, se observa una Fibrilación Ventricular (FV), ¿cuál es la dosis de energía recomendada para la primera descarga de desfibrilación?

A) 1 J/kg

B) 2 J/kg *

C) 4 J/kg

D) 10 J/kg

Retroalimentación 2:

La secuencia de desfibrilación en pediatría inicia con 2 J/kg. La segunda descarga es de 4 J/kg, y las subsecuentes pueden subir hasta un máximo de 10 J/kg o dosis de adulto.

Tema: PEDIATRÍA / URGENCIAS

Subtema: QUEMADURAS (EXTENSIÓN Y LÍQUIDOS)

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Preescolar de 3 años, con peso de 15 kg, sufre quemadura por escaldadura (agua hirviendo) que afecta toda la extremidad superior derecha y la cara anterior del tronco.

Pregunta 1

¿Cuál es el método más preciso para calcular la superficie corporal quemada (SCQ) en niños, considerando que la cabeza es proporcionalmente más grande que en adultos?

A) Regla de los 9 de Wallace

B) Gráfica de Lund-Browder *

C) Regla de la palma de la mano (1%)

D) Fórmula de Currarino

Retroalimentación 1:

La Regla de los 9 es inexacta en niños. La tabla de Lund-Browder ajusta los porcentajes según la edad, asignando más valor a la cabeza en niños pequeños. La palma del paciente (incluyendo dedos) representa aproximadamente el 1% de su SCQ y es útil para quemaduras pequeñas o dispersas.

Pregunta 2

Utilizando la Fórmula de Parkland (GPC), ¿cuál es el volumen total de solución Ringer Lactato a administrar en las primeras 24 horas si se calcula una SCQ del 20%?

A) 1,200 ml (4 ml x kg x %SCQ) *

B) 600 ml

C) 2,400 ml

D) 3,000 ml

Retroalimentación 2:

La fórmula de Parkland dicta 4 ml/kg/%SCQ. En este caso: 4 x 15 x 20 = 1,200 ml. La mitad (600 ml) se pasa en las primeras 8 horas y el resto en las siguientes 16 horas. Nota: En niños, además de Parkland, se deben sumar los líquidos de mantenimiento (Holliday-Segar).

Tema: PEDIATRÍA / URGENCIAS

Subtema: CHOQUE HIPOVOLÉMICO

Dificultad: Media

Caso clínico (Corto):

Lactante con deshidratación grave por diarrea. Presenta alteración del estado de conciencia, piel fría y moteada, pulsos filiformes y llenado capilar de 5 segundos. Se decide acceso intraóseo ante la imposibilidad de vía periférica.

Pregunta 1

¿Cuál es el sitio anatómico de primera elección para la colocación de una aguja intraósea en un niño menor de 6 años?

A) Maléolo medial

B) Cara anterior de la tibia (2 cm debajo de la tuberosidad tibial) *

C) Esternón

D) Cresta iliaca anterior

Retroalimentación 1:

La tibia proximal es el sitio preferido por su fácil acceso y médula ósea altamente vascularizada. Es una vía temporal (máximo 24h) para administración de líquidos y fármacos durante la reanimación.

Pregunta 2

¿Cuál es la meta de gasto urinario que indica una adecuada reanimación hídrica en un lactante?

A) > 0.5 ml/kg/hr

B) > 1 ml/kg/hr *

C) > 5 ml/kg/hr

D) 10 ml/hr total

Retroalimentación 2:

En lactantes, la meta es ≥1 ml/kg/hr. En niños mayores y adolescentes, ≥0.5 ml/kg/hr es aceptable.

Tema: PEDIATRÍA / PSIQUIATRÍA INFANTIL

Subtema: TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD (TDAH)

Dificultad: Media

Caso clínico (Largo):

Escolar de 7 años es referido por su maestra debido a que "no puede estar sentado", interrumpe constantemente a sus compañeros, pierde sus útiles escolares y no sigue instrucciones completas. Los síntomas se presentan tanto en la escuela como en casa desde los 5 años. A la exploración en el consultorio, el niño se muestra inquieto, cambia de actividad rápidamente y responde antes de que se termine la pregunta.

Pregunta 1

De acuerdo con la GPC, ¿cuáles son los tres subtipos de TDAH y a partir de qué edad se recomienda realizar el diagnóstico formal?

A) Cognitivo, Motor y Social; 3 años

B) Inatento, Hiperactivo-Impulsivo y Combinado; 6 años *

C) Leve, Moderado y Grave; 10 años

D) Primario, Secundario y Terciario; 12 años

Retroalimentación 1:

El TDAH se clasifica en tres presentaciones: predominio de inatención, predominio de hiperactividad/impulsividad o combinado. La GPC mexicana sugiere que el diagnóstico clínico se establezca idealmente a partir de los 6 años, cuando las exigencias académicas hacen evidentes los síntomas que deben estar presentes en al menos dos ambientes (casa y escuela).

Pregunta 2

¿Cuál es el tratamiento farmacológico de primera línea (psicoestimulante) recomendado en México para pacientes con TDAH de moderado a grave?

A) Fluoxetina

B) Metilfenidato *

C) Risperidona

D) Clonidina

Retroalimentación 2:

El metilfenidato es el fármaco de primera elección debido a su eficacia en mejorar la neurotransmisión dopaminérgica en la corteza prefrontal. La atomoxetina se considera de segunda línea o en casos de comorbilidad con tics o ansiedad.

Tema: PEDIATRÍA / PSIQUIATRÍA INFANTIL

Subtema: TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA)

Dificultad: Alta

Caso clínico (Largo):

Lactante de 22 meses es llevado por sus padres porque "parece que no escucha" y aún no dice palabras con sentido. Al observarlo en consulta, el niño no realiza contacto visual, no señala objetos para mostrar interés (atención conjunta) y se molesta intensamente ante ruidos fuertes. Presenta movimientos estereotipados con las manos (aleteo).

Pregunta 1

¿Cuál es la herramienta de tamizaje (screening) validada en México que se debe aplicar ante la sospecha de TEA entre los 16 y 30 meses de edad?

A) Cuestionario de Madurez Neuropsicológica (CUMANIN)

B) M-CHAT-R/F (Cuestionario Modificado de Autismo en Niños Pequeños) *

C) Escala de Denver

D) Test de Conners

Retroalimentación 1:

El M-CHAT es la herramienta de tamizaje más utilizada y recomendada por la GPC para detección temprana. No es diagnóstica por sí sola, pero identifica niños en riesgo que requieren evaluación especializada.

[Image of early signs of autism spectrum disorder]

Pregunta 2

¿Cuál es el pilar del tratamiento no farmacológico que ha demostrado mayor evidencia en la mejoría funcional de estos pacientes?

A) Terapia de integración sensorial únicamente

B) Análisis Conductual Aplicado (Terapia ABA) y programas de comunicación *

C) Dieta libre de gluten y caseína

D) Suplementación con Omega-3

Retroalimentación 2:

Las intervenciones educativas y conductuales (como el modelo ABA) son el estándar de oro para mejorar el lenguaje y las habilidades sociales. No hay evidencia científica sólida para las dietas restrictivas en TEA.

Tema: PEDIATRÍA / PSIQUIATRÍA INFANTIL

Subtema: TRASTORNO NEGATIVISTA DESAFIANTE (TND)

Dificultad: Media

Caso clínico (Corto):

Escolar de 8 años con antecedentes de desobediencia persistente hacia figuras de autoridad, discute con adultos, se niega a cumplir normas y culpa a otros de sus errores. Las conductas tienen una duración de 8 meses. No presenta conductas delictivas ni agresión física grave a terceros.

Pregunta 1

¿Cuál es la diferencia fundamental entre el Trastorno Negativista Desafiante (TND) y el Trastorno de la Conducta (Disocial) según el DSM-5?

A) El TND no incluye violación de los derechos básicos de los demás o agresión grave; el Disocial sí *

B) El TND solo ocurre en la adolescencia

C) El TND requiere hospitalización inmediata

D) No hay diferencia, son el mismo trastorno

Retroalimentación 1:

El TND es un patrón de humor irritable y conducta desafiante. El Trastorno de la Conducta es más grave, implicando crueldad animal, robo, vandalismo o agresión física (violación de derechos ajenos). El tratamiento inicial del TND se basa en terapia familiar y entrenamiento para padres.

Tema: PEDIATRÍA / REUMATOLOGÍA

Subtema: FIEBRE REUMÁTICA (FR)

Dificultad: Media

Caso clínico (Largo):

Escolar de 9 años acude por dolor articular migratorio que afecta rodilla derecha y ahora tobillo izquierdo, con signos de inflamación franca. Antecedente de faringoamigdalitis purulenta hace 3 semanas. A la exploración física se detecta un soplo holosistólico apical (sugerente de insuficiencia mitral) y nódulos subcutáneos firmes en superficies extensoras.

Pregunta 1

De acuerdo con los Criterios de Jones (GPC), ¿cuál de las siguientes combinaciones confirma el diagnóstico de un primer episodio de Fiebre Reumática?

A) 1 Criterio Mayor + 1 Menor + Evidencia de infección por Estreptococo (ASLO+)

B) 2 Criterios Mayores + Evidencia de infección por Estreptococo (ASLO+) *

C) 3 Criterios Menores únicamente

D) Presencia de Corea de Sydenham aislada

Retroalimentación 1:

Para el diagnóstico inicial se requieren 2 criterios mayores O 1 mayor + 2 menores, siempre acompañados de evidencia de infección previa por Estreptococo betahemolítico del grupo A (títulos de ASLO elevados o cultivo faríngeo positivo). Los criterios mayores son: Poliartritis migratoria, Carditis, Nódulos subcutáneos, Eritema marginado y Corea.

Pregunta 2

¿Cuál es el tratamiento de elección para la erradicación del estado de portador y la profilaxis secundaria en un paciente sin alergia a la penicilina?

A) Penicilina G Benzatínica (1.2 millones UI cada 21-28 días) *

B) Amoxicilina por 7 días

C) Eritromicina de por vida

D) Ceftriaxona mensual

Retroalimentación 2:

La penicilina benzatínica intramuscular es el estándar de oro para prevenir recurrencias que dañen más las válvulas cardiacas. En pacientes con carditis residual, la profilaxis puede extenderse por 10 años o hasta los 21-40 años de edad según la severidad.

Tema: PEDIATRÍA / INMUNOLOGÍA

Subtema: INMUNODEFICIENCIA COMBINADA GRAVE (IDCG)

Dificultad: Alta

Caso clínico (Largo):

Lactante de 4 meses presenta candidiasis oral persistente (que no cede a nistatina), diarrea crónica y tres episodios de neumonía, uno de ellos confirmado por

Pneumocystis jirovecii. En la biometría hemática destaca linfopenia severa (<1,000 linfocitos totales). La radiografía de tórax muestra ausencia de sombra tímica.

Pregunta 1

¿Cuál es la sospecha diagnóstica más probable y cuál es el tratamiento definitivo para esta "emergencia inmunológica"?

A) Agammaglobulinemia de Bruton; Gammaglobulina IV mensual

B) Inmunodeficiencia Combinada Grave (Niño Burbuja); Trasplante de Células Progenitoras Hematopoyéticas *

C) Síndrome de DiGeorge; Suplementación con Calcio

D) VIH pediátrico; Antirretrovirales

Retroalimentación 1:

La IDCG se caracteriza por la falla tanto de linfocitos T como B. El dato clave es la linfopenia profunda y la ausencia de timo. Es una emergencia porque, sin trasplante de médula ósea, los pacientes suelen fallecer antes del primer año de vida por infecciones oportunistas.

Pregunta 2

¿Qué tipo de vacunas están ABSOLUTAMENTE CONTRAINDICADAS en este paciente?

A) Vacunas de virus vivos atenuados (ej. Rotavirus, SRP, Varicela) *

B) Vacunas inactivadas (ej. Hexavalente)

C) Vacuna contra Neumococo

D) Vacuna contra Influenza estacional

Retroalimentación 2:

En cualquier inmunodeficiencia celular grave, las vacunas de virus vivos pueden causar la enfermedad diseminada y ser fatales.

Tema: PEDIATRÍA / INMUNOLOGÍA

Subtema: AGAMMAGLOBULINEMIA LIGADA AL X (BRUTON)

Dificultad: Media

Caso clínico (Corto):

Lactante masculino de 8 meses inicia con cuadros repetitivos de otitis media y neumonía por bacterias encapsuladas (S. pneumoniae, H. influenzae). Los síntomas iniciaron después de los 6 meses de vida. Laboratorios: Ausencia de linfocitos B periféricos (CD19/CD20) y niveles muy bajos de todas las inmunoglobulinas (IgG, IgA, IgM).

Pregunta 1

¿Por qué los síntomas suelen iniciar después de los 6 meses de vida en esta patología?

A) Por la exposición a la guardería

B) Porque a esa edad desaparecen los anticuerpos IgG maternos transplacentarios *

C) Por el inicio de la ablactación

D) Debido a la maduración del sistema del complemento

Retroalimentación 1:

La Agammaglobulinemia de Bruton afecta solo a varones (ligada al X). Los bebés están "protegidos" los primeros meses por la IgG que la madre les pasó en el embarazo. Una vez que esta disminuye, quedan vulnerables a bacterias piógenas.

Tema: PEDIATRÍA / NUTRICIÓN

Subtema: DESNUTRICIÓN PROTEICO-CALÓRICA (KWASHIORKOR VS MARASMO)

Dificultad: Media

Caso clínico (Largo):

Lactante de 18 meses, cuya dieta se basa exclusivamente en atoles de maíz y caldos desde el destete a los 6 meses. A la exploración física se observa edema generalizado (anasarca) que deja fóvea, abdomen globoso por hepatomegalia (esteatosis hepática), cabello quebradizo y rojizo ("signo de la bandera") y lesiones cutáneas descamativas en "pintura loca". El niño se muestra sumamente apático e irritable.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico clínico de este tipo de desnutrición y cuál es el hallazgo laboratorial más característico?

A) Marasmo; Hipoglucemia extrema

B) Kwashiorkor (Desnutrición proteica); Hipoalbuminemia severa *

C) Escorbuto; Deficiencia de Vitamina C

D) Raquitismo; Niveles bajos de Calcio

Retroalimentación 1:

El Kwashiorkor es la desnutrición cualitativa (falta de proteínas con ingesta de carbohidratos). El edema se explica por la baja presión oncótica debida a la hipoalbuminemia. El "signo de la bandera" refleja periodos de ingesta proteica intermitente que alteran la pigmentación del cabello.

Pregunta 2

¿Cuál es la complicación hidroelectrolítica más peligrosa que ocurre durante la fase inicial de recuperación (re alimentación rápida) en un desnutrido grave?

A) Hipernatremia

B) Síndrome de Realimentación (Hipofosfatemia, hipopotasemia e hipomagnesemia) *

C) Hipercalcemia

D) Acidosis láctica

Retroalimentación 2:

Al reintroducir carbohidratos, la insulina se eleva y mete fósforo, potasio y magnesio a las células, lo que puede causar falla cardiaca y muerte. La GPC recomienda iniciar la alimentación de forma lenta y vigilando electrolitos.

Tema: PEDIATRÍA / NUTRICIÓN

Subtema: MARASMO (DESNUTRICIÓN CALÓRICA)

Dificultad: Baja

Caso clínico (Corto):

Lactante de 8 meses con peso y talla muy por debajo del percentil 3. A la exploración se observa pérdida severa de tejido adiposo y muscular, costillas prominentes y cara de "viejito" o "pasa" por pérdida de las bolsas de Bichat. El niño tiene un apetito voraz pero no ha recibido suficiente aporte lácteo.

Pregunta 1

¿Cómo se clasifica esta desnutrición y cuál es el indicador antropométrico que se afecta de forma más temprana en la desnutrición aguda?

A) Marasmo; Peso para la Talla (P/T) *

B) Kwashiorkor; Talla para la Edad (T/E)

C) Sobrepeso; Perímetro cefálico

D) Desnutrición crónica; Peso para la Edad (P/E)

Retroalimentación 1:

El Marasmo es el grado extremo de adaptación a la inanición (falta de calorías totales). El indicador P/T mide la desnutrición aguda (emaciación), mientras que T/E mide la desnutrición crónica (desmedro o stunting).

Tema: PEDIATRÍA / NUTRICIÓN

Subtema: RAQUITISMO (DEFICIENCIA DE VITAMINA D)

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Lactante de 10 meses con lactancia materna exclusiva sin suplementación. A la exploración física se detecta rosario raquítico (abultamiento de las uniones costocondrales), craneotabes (huesos del cráneo blandos) y ensanchamiento de las muñecas. El niño aún no gatea por debilidad muscular.

Pregunta 1

¿Cuál es la causa fisiopatológica del raquitismo y qué hallazgo radiológico se espera encontrar en las metáfisis de los huesos largos?

A) Exceso de Vitamina A; Cierre prematuro de fisis

B) Deficiencia de Vitamina D que impide la mineralización del hueso; Imagen en "copa" o "deshilachamiento" metafisiario *

C) Intoxicación por Plomo; Líneas de plomo

D) Deficiencia de Vitamina C; Signo de Wimberger

Retroalimentación 1:

La Vitamina D es esencial para la absorción de calcio. Sin ella, el osteoide no se mineraliza. Radiológicamente, las metáfisis se ven anchas y cóncavas (en copa). La

GPC recomienda suplementar con 400 UI de Vitamina D al día a todos los lactantes con lactancia materna exclusiva.

Tema: PEDIATRÍA / NUTRICIÓN

Subtema: VITAMINA A Y K

Dificultad: Baja

Caso clínico (Corto):

Recién nacido de 2 días de vida, nacido en casa sin atención médica. Presenta sangrado activo por el cordón umbilical y equimosis múltiples.

Pregunta 1

¿Qué deficiencia vitamínica es la causa más probable y cuál es la dosis profiláctica que debió recibir al nacer según la GPC?

A) Vitamina A; 50,000 UI

B) Vitamina K; 1 mg intramuscular (IM) *

C) Vitamina C; 100 mg

D) Vitamina E; 5 mg

Retroalimentación 1:

La enfermedad hemorrágica del recién nacido ocurre por la deficiencia de factores de coagulación dependientes de Vitamina K (II, VII, IX, X). La profilaxis con 1 mg IM es obligatoria en todo recién nacido en México.

Tema: PEDIATRÍA / ADOLESCENCIA

Subtema: DESARROLLO PUBERAL (ESCALA DE TANNER)

Dificultad: Media

Caso clínico (Largo):

Niña de 11 años acude a revisión. A la exploración física se observa: elevación de la mama y el pezón como un pequeño montículo con aumento del diámetro de la aureola (Botón mamario). El vello púbico es escaso, largo, ligeramente pigmentado, liso o levemente rizado, localizado principalmente a lo largo de los labios mayores. No ha presentado la menarquia.

Pregunta 1

¿En qué estadios de Tanner (Mamario y Vello Púbico) se encuentra la paciente y cuál es el primer signo de desarrollo puberal en las niñas?

A) Tanner M2, VP2; Telarquia *

B) Tanner M3, VP3; Pubarquia

C) Tanner M1, VP1; Adrenarquia

D) Tanner M4, VP2; Menarquia

Retroalimentación 1:

La telarquia (botón mamario) es el primer signo de pubertad en el 90% de las niñas, seguido de la pubarquia (vello). El estadio M2 de Tanner corresponde precisamente a la aparición del botón mamario.

Pregunta 2

¿En qué momento del desarrollo puberal (Tanner) suele presentarse el pico de velocidad de crecimiento (estirón) en las niñas y cuánto tiempo después de la telarquia suele aparecer la menarquia?

A) Tanner M2; 6 meses después

B) Tanner M2-M3; 2 años después de la telarquia *

C) Tanner M5; 5 años después

D) Tanner M4; Inmediatamente

Retroalimentación 2:

Las niñas dan el "estirón" más temprano que los niños (Tanner 2-3). La menarquia es un evento tardío (Tanner 4) que ocurre aproximadamente 2 años después de la aparición del botón mamario.

Tema: PEDIATRÍA / ADOLESCENCIA

Subtema: DESARROLLO PUBERAL MASCULINO

Dificultad: Media

Caso clínico (Corto):

Adolescente masculino de 13 años. A la exploración se detecta un volumen testicular de 5 ml (medido con orquidómetro de Prader) y adelgazamiento del escroto con cambio en su textura. Se observa vello púbico escaso en la base del pene.

Pregunta 1

¿Cuál es el primer signo clínico de pubertad en el varón y a partir de qué volumen testicular se considera iniciado el proceso?

A) Aparición de vello axilar; 2 ml

B) Crecimiento testicular; ≥ 4 ml *

C) Aumento del tamaño del pene; 6 ml

D) Cambio de voz; 10 ml

Retroalimentación 1:

El primer signo de pubertad masculina es el aumento del volumen testicular (≥4 ml o >2.5 cm de longitud), debido al estímulo de las gonadotropinas sobre las células de Sertoli y Leydig.

Tema: PEDIATRÍA / ADOLESCENCIA

Subtema: TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA (ANOREXIA NERVIOSA)

Dificultad: Alta

Caso clínico (Largo):

Adolescente de 15 años es traída por pérdida de peso de 10 kg en 3 meses. La paciente refiere que "se siente gorda" a pesar de tener un IMC de 16 kg/m^2. Presenta amenorrea de 4 meses, piel seca, lanugo en espalda y bradicardia (FC 48 lpm). Niega provocarse el vómito, pero realiza ejercicio extenuante 4 horas al día.

Pregunta 1

¿Cuál es el hallazgo laboratorial más común en la anorexia nerviosa y cuál es el criterio de hospitalización inmediata por riesgo vital según la GPC?

A) Hiperpotasemia; IMC de 18

B) Hipopotasemia y alteraciones del ECG (prolongación de QT); Bradicardia <40 lpm o inestabilidad hemodinámica *

C) Hiperglucemia; Amenorrea

D) Leucocitosis; Pérdida del 5% del peso

Retroalimentación 1:

La anorexia nerviosa tiene una alta mortalidad. La desnutrición extrema causa bradicardia y prolongación del QT, lo que predispone a arritmias. La hipopotasemia es común, especialmente si hay purgas (vómitos/laxantes).

Pregunta 2

¿Cómo se denomina el patrón hormonal característico de la amenorrea en pacientes con anorexia nerviosa?

A) Hipogonadismo hipergonadotrópico

B) Hipogonadismo hipogonadotrópico (FSH y LH bajas) *

C) Hiperprolactinemia

D) Síndrome de Ovario Poliquístico

Retroalimentación 2:

La pérdida de grasa corporal crítica interrumpe la secreción pulsátil de GnRH en el hipotálamo, lo que lleva a niveles bajos de gonadotropinas y, por ende, de estrógenos.

Tema: PEDIATRÍA / ADOLESCENCIA

Subtema: GINECOMASTIA PUBERAL

Dificultad: Baja

Caso clínico (Corto):

Varón de 14 años, Tanner G3, presenta crecimiento mamario bilateral de 2 cm, ligeramente doloroso a la palpación, localizado debajo de la areola. No presenta secreción por el pezón ni masas pétreas.

Pregunta 1

¿Cuál es la conducta más adecuada según la GPC mexicana para la ginecomastia puberal fisiológica?

A) Mastectomía subcutánea inmediata

B) Iniciar tratamiento con tamoxifeno

C) Observación y tranquilidad (suele involucionar en 1-2 años) *

D) Solicitar TAC de abdomen para buscar tumores suprarrenales

Retroalimentación 1:

Hasta el 50-60% de los adolescentes varones presentan ginecomastia transitoria por un desbalance temporal entre estrógenos y testosterona. Si es <4 cm y está en etapas medias de la pubertad, la conducta es expectante.

Tema: PEDIATRÍA / SEGURIDAD

Subtema: SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA DEL LACTANTE (SMSL)

Dificultad: Baja

Caso clínico (Medio):

Madre primeriza acude a consulta de niño sano con su lactante de 2 meses. Pregunta sobre las mejores condiciones para dormir al bebé, ya que tiene miedo de que "se asfixie" mientras ella duerme.

Pregunta 1

De acuerdo con las recomendaciones internacionales y la GPC, ¿cuál es la posición más segura para dormir a un lactante y qué factor del entorno aumenta significativamente el riesgo de SMSL?

A) Posición lateral; Uso de almohadas delgadas

B) Posición supina (boca arriba); Tabaquismo pasivo y dormir en superficies blandas *

C) Posición prona (boca abajo); Uso de chupón

D) Posición supina; Compartir la cama con los padres (colecho) es siempre protector

Retroalimentación 1:

La posición supina es la medida preventiva número uno. El tabaquismo prenatal y postnatal, así como el exceso de ropa de cama (almohadas, peluches), son factores de riesgo mayores. El uso de chupón, por el contrario, se ha asociado con un efecto protector. El colecho se desaconseja, prefiriendo que el niño duerma en la misma habitación pero en su propia cuna.

Tema: PEDIATRÍA / ASPECTOS LEGALES

Subtema: ABUSO SEXUAL INFANTIL

Dificultad: Alta

Caso clínico (Largo):

Niña de 6 años es traída por su tía debido a que la menor presenta disuria, secreción vaginal amarillenta y cambios bruscos de comportamiento (pesadillas y regresión en el control de esfínteres). A la exploración bajo sedación, se observa eritema vulvar severo y una laceración en la horquilla vulvar posterior. Se toma cultivo de la secreción.

Pregunta 1

¿Cuál es el hallazgo laboratorial (microbiológico) que se considera evidencia definitiva de contacto sexual en un niño o niña antes de la pubertad?

A) Presencia de Candida albicans

B) Aislamiento de Neisseria gonorrhoeae o Trichomonas vaginalis *

C) Gardnerella vaginalis en frotis

D) Infección por Virus del Papiloma Humano (VPH) tipo 6 u 11

Retroalimentación 1:

Aunque el VPH puede transmitirse de forma no sexual (fómites/canal de parto), la gonorrea y la tricomoniasis en pacientes prepúberes son marcadores biológicos de abuso sexual hasta que se demuestre lo contrario.

Pregunta 2

Según la NOM-046-SSA2-2005, ¿cuál es el periodo máximo para administrar la profilaxis antirretroviral (VIH) y la anticoncepción de emergencia tras una agresión sexual?

A) Antirretrovirales hasta las 72 horas; Anticoncepción hasta las 120 horas *

B) Antirretrovirales hasta los 7 días; Anticoncepción hasta las 48 horas

C) Solo si hay embarazo confirmado; Solo si el agresor es VIH positivo

D) No se recomienda profilaxis en menores de 12 años

Retroalimentación 2:

La NOM-046 es muy clara: la profilaxis para VIH debe iniciarse idealmente en las primeras horas y máximo a las 72 horas del evento. La anticoncepción de emergencia es efectiva hasta las 120 horas (5 días), aunque su eficacia disminuye con el tiempo.

Tema: PEDIATRÍA / PREVENCIÓN

Subtema: SEGURIDAD EN EL AUTOMÓVIL

Dificultad: Media

Caso clínico (Corto):

Padres de un lactante de 9 kg de peso preguntan sobre la instalación de la silla de seguridad en su vehículo.

Pregunta 1

¿Cuál es la recomendación actual de la GPC sobre la orientación de la silla de seguridad para niños pequeños?

A) Siempre mirando hacia adelante

B) Mirando hacia atrás el mayor tiempo posible (mínimo hasta los 2 años o alcanzar peso límite) *

C) En el asiento del copiloto con bolsa de aire activada

D) Solo es necesaria a partir de los 15 kg

Retroalimentación 1:

Las sillas orientadas hacia atrás protegen mucho mejor el cuello y la columna de los lactantes ante un impacto frontal, que es el accidente más común.

Tema: PEDIATRÍA / INTOXICACIONES

Subtema: INTOXICACIÓN POR PLOMO (SATURNISMO)

Dificultad: Media

Caso clínico (Corto):

Niño de 4 años que vive en una casa antigua con pintura descascarada presenta irritabilidad, dolor abdominal crónico y retraso en el lenguaje. La biometría hemática reporta anemia microcítica con punteado basófilo en los eritrocitos.

Pregunta 1

¿Cuál es el nivel sérico de plomo que la GPC considera como umbral para iniciar intervención ambiental y cuál es el tratamiento quelante de elección si los niveles superan los 45 µg/dL?

A) > 2 µg/dL; Penicilamina

B) > 5 µg/dL; Succímero (DMSA) vía oral o Edetato de calcio disódico (EDTA) *

C) > 20 µg/dL; Carbón activado

D) > 50 µg/dL; Diálisis

Retroalimentación 1:

El punteado basófilo es la "pista" clásica del ENARM para saturnismo. Los niveles superiores a 5 µg/dL requieren investigación de la fuente. El Succímero es el quelante oral de elección para niveles moderados/altos sin encefalopatía.

Tema: PEDIATRÍA / INMUNIZACIONES

Subtema: ESQUEMA DE RESCATE (VACUNA HEXAVALENTE)

Dificultad: Alta

Caso clínico (Largo):

Lactante de 14 meses es traído por primera vez a la unidad de salud. No cuenta con antecedentes de vacunación previos, excepto BCG y Hepatitis B al nacer. La madre desea ponerlo al corriente.

Pregunta 1

De acuerdo con el Manual de Vacunación y la GPC mexicana, ¿cuántas dosis de la vacuna Hexavalente acelular (DPaT+VPI+Hib+HB) debe recibir este niño para completar su esquema primario dada su edad actual?

A) 4 dosis (esquema normal)

B) 2 dosis con intervalo de 4 semanas entre ellas

C) 3 dosis (0, 2 y 6 meses a partir de hoy) *

D) Solo 1 dosis porque ya es mayor de un año

Retroalimentación 1:

En niños de 1 a 4 años con esquema incompleto, la GPC indica un esquema de rescate de 3 dosis para asegurar inmunidad contra Difteria, Tétanos y Tos ferina. La primera hoy, la segunda a las 4 semanas y la tercera a los 6 meses de la primera. No se aplica el refuerzo de los 18 meses si no han pasado 6 meses de la última dosis del esquema primario.

Tema: PEDIATRÍA / INMUNIZACIONES

Subtema: REACCIONES ADVERSAS (ESAVI)

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Lactante de 2 meses recibe sus vacunas correspondientes (Hexavalente, Rotavirus y Neumococo). A las 6 horas, presenta llanto inconsolable, persistente por más de 3 horas, y fiebre de 38.5°C. No hay convulsiones ni alteración del estado de alerta.

Pregunta 1

¿Cuál de los componentes de la vacuna es el responsable más frecuente de este cuadro de "llanto persistente" y cuál es la conducta recomendada?

A) Neumococo; Hospitalizar para punción lumbar

B) Fracción Pertussis (Tos ferina); Manejo sintomático con paracetamol y vigilancia en casa *

C) Rotavirus; Realizar ultrasonido abdominal

D) Hepatitis B; Suspender dosis subsecuentes

Retroalimentación 1:

El componente de Bordetella pertussis (incluso en su forma acelular) es el más reactogénico. El llanto persistente (>3 horas) es un ESAVI común pero no contraindica dosis futuras. Diferente sería un "Episodio Hipotónico-Hiporreactivo" o anafilaxia, que sí obligarían a suspender el componente de Pertussis.

Tema: PEDIATRÍA / INMUNIZACIONES

Subtema: VACUNA CONTRA ROTAVIRUS

Dificultad: Alta

Caso clínico (Corto):

Lactante de 8 meses y 2 semanas acude a consulta. No tiene ninguna dosis previa de la vacuna contra Rotavirus. La madre solicita que se le aplique.

Pregunta 1

¿Cuál es la conducta correcta según la GPC y cuál es la razón principal de esta restricción de edad?

A) Aplicarla de inmediato; Riesgo de diarrea grave

B) No aplicarla; La edad máxima para la última dosis es de 7 meses con 29 días por riesgo de invaginación intestinal *

C) Aplicar media dosis; Riesgo de fiebre

D) Aplicar solo si asiste a guardería

Retroalimentación 1:

La vacuna contra Rotavirus tiene ventanas de aplicación estrictas. La primera dosis no debe darse después de las 14 semanas y 6 días. La última dosis (segunda o tercera según la marca) tiene como límite los 8 meses cumplidos (7m 29d). Pasada esa edad, el riesgo basal de invaginación intestinal aumenta y la vacuna ya no se recomienda.

Tema: PEDIATRÍA / INMUNIZACIONES

Subtema: VACUNA BCG (TUBERCULOSIS)

Dificultad: Baja

Caso clínico (Corto):

Recién nacido de 3,200 g, sano, hijo de madre con VIH que recibió tratamiento antirretroviral y tiene carga viral indetectable. El niño iniciará profilaxis con zidovudina.

Pregunta 1

¿Está indicada la aplicación de la vacuna BCG en este recién nacido según la GPC?

A) Sí, es obligatoria al nacer sin importar el estado de la madre

B) No, está contraindicada hasta confirmar que el niño es VIH negativo mediante PCR *

C) Sí, pero a media dosis

D) Solo si vive en zona rural

Retroalimentación 1:

La BCG es una vacuna de bacilos vivos atenuados. En hijos de madres con VIH, debe diferirse su aplicación hasta que se descarte la infección en el niño (PCR negativa), debido al riesgo de "BCGitis" diseminada si el niño resultara inmunocomprometido.